İçindekiler

1. ACS Florrian 2
2. Akute Appendizitis 5
3. Akute Gastroenteritis 8
4. Akute Pyelonephritis 11
5. Asthma 14
6. Burn Out 17
7. Choledocholithiasis 21
8. Divertikülitis 24
9. Entgleister DM 27
10. GERD 30
11. HWS 33
12. Hyperthyreose 39
13. LUMBALGIE 42
14. Mesenterial Infarkt 45
15. OSAS 48
16. PNEUMONIE 51
17. Pankreatitis 54
18. RDS 57
19. SLE 60
20. UAW von Chemotherapie 63
21. Urolithiasis 68

1. ACS Florrian

İçindekilere dön

• **Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach Stress oder *Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?*** • Sind Sie bei Belastung oder auch in Ruhe aufgetreten? • Ist Ihnen Schwindel? • Haben Sie schon Bewustsein verloren? • Haben Sie Todesagst? • Fühlen Sie sich Müde? • Haben Sie Klatschweiß? • Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Seit wann?	• Haben Sie Probleme beim Treppensteigen? Wie viele Etagen können Sie ohne Probleme gehen? • **Haben Sie geschwollene, gerötete oder überwärmte Beine bemerkt?** (= Ist Ihnen eine Schwellung, Rötung oder Überwärmung der Beine aufgefallen?) *(um LUE auszuschliesen)* • **Leiden Sie unter Sodbrennen oder saurem Aufstoßen?** *(um GERD auszuschliesen)*

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Durchblutstörung des Herzen (Herzkranzgefäßverengung).**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen . Ich habe schon (während des Gesprächs) Ihnen Blut für das Labor abgenommen und einen EKG geschrieben. Darüber hinaus werde ich einen Herzultraschall durchführen.

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über meinen Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Herrn Florian Willms . **Er ist** 42 **Jahre alt, geboren am** 02.02.1984 **Er ist** 1,87 **m groß und wiegt** 94,5 **kg**.

Er **kam heute zu uns wegen heute Morgen aufgetretener retrosternaler Brustschmerzen in Ruhe, mit Ausstrahlung in den linken Arm und in den Hals**

Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen plötzlich in Ruhe **aufgetreten.**

Er **berichtet, dass die Schmerzen in** den linken Arm und in den Hals **ausstrahlen.**

Nach Angaben des Patienten waren die Schmerzen zunächst stechend, brennend, ziehend und dumpf, später wurden sie eher als drückend beschrieben.

Schmerzintensität lag zu Beginn bei 5–6 von 10, aktuell bei 3–4 von 10 **auf der NRS**.

Wegen dieser Schmerzen musste ich das Gespräch unterbrcehen, um das abzuklären. Dann habe ich das Gespräch weitergeführt.

Außerdem erwähnt er , dass er ähnliche Beschwerden in den letzten zwölf Monaten hat, insgesamt 2–3 Episoden, jeweils bei Belastung, insbesondere beim Treppensteigen. Diese Attacken dauerten etwa 30 Minuten und verschwanden in Ruhe.

Begleitend klagt er heute **über** Kaltschweißigkeit, Übelkeit, Schwindel, Schwarzwerden vor Augen, Fatigue, Palpitationen und Blässe.

Vegetativanamnestisch ergaben sich Inappetenz, eine Gewichtszunahme von 3 kg inerhalb von letzten 3 Jahren und Insomnie.

An Vorerkrankungen sind ein chronischer Husten mit Auswurf aufgrund des Nikotinkonsums sowie eine durchgemachte Zytomegalievirus-Infektion im Alter von 25 Jahren mit Lymphknotenschwellungen **bekannt.**

An Operationen ist eine Operationen sind eine Unterschenkeloperation links nach einem Autounfall,

Bei der Noxenanamnese erwähnte er 14 py Nikotinkonsum , 1-2 Flaschen Bier oder 2-3 Gläser Wein am Wochenende.

Die Familienanamnese ergab aHT, Glaukom und MI **beim Vater,** an dem er gestroben ist**,** und rheumatoiden Arthritis **bei der Mutter** und Adipositas, Depressionen und Varizen **bei der Schwester.**

Sozialanamnestisch ist er Speditionskaufmann.Früher hat er als Schlosser gearbeitet. Er ist getrent von seiner Frau, hat eine Tochter. Er hat Stress sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein **akutes Koronarsyndrom (ACS)**. **Dafür sprechen** die plötzlich aufgetretenen retrosternalen, stechend-dumpf-drückenden Brustschmerzen in Ruhe, die Progredienz seit mehreren Monaten sowie die Begleitsymptome (Palpitationen, Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Schwindel, Schwarzwerden vor Augen, Fatigue, Blässe)

Differentialdiagnostisch kommen eine Lungenembolie (LAE) sowie ein gastroösophagealer Reflux (GERD) **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen .

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu wiederholen.

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Gerinnungsparametern (einschließlich D-Dimere) / Elektrolyte, Leber-, Nierenwerte, TSH, Herzmuskelenzyme (Troponine I, CKMB), LDH, Lipidprofil **bestimmen lassen.**
Des Weiteren werde ich Echokardiografie, Röntgen-Thorax, **durchführen**, sowie ein CT-Angiographie **veranlassen**

Zudem werde ich ein **sofortige**s kardiologisches Konsil **anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten **intensivstationär aufnehmen**.
Als initiale Therapie empfehle ich MONA-BH-Schema:

Morphin (3 mg i.v., ggf. wiederholt),- Morphin 3 mg intravenös, bei Bedarf kann die Gabe wiederholt werden.

Sauerstoffgabe (bei SpO_2 < 90%),-Saue rstoffgabe bei einer Sättigung unter 90 Prozent.

Nitroglycerin (sofern keine Hypotonie vorliegt),- Nitroglycerin sublingual oder als Spray, nicht bei Hypotonie

ASS 300 mg i.v.,- Aspirin 300 mg intravenös als Bolus.

Heparin 5000 IE i.v.,- Heparin 5000 Internationale Einheiten intravenös als Bolus.

Clopidogrel 600 mg p.o.

(Zusätzlich verordne ich) bei Bedarf **Antiemetika** sowie **Sedativa**.

Weiterhin (habe ich ein **kardiologisches Konsil** veranlasst. Je nach Befund erwägen wir eine) Koronarangiografie mit ggf. perkutaner Koronarintervention (PCI) oder **Bypass-Operation**

- Es soll eine konsequente **Nikotinkarenz und Alkoholkarenz** eingehalten werden. Parallel ist eine **Patientenschulung** sowie eine **Stressbewältigungstherapie** vorgesehen.

2. Akute Appendizitis

İçindekilere dön

• **Sind die Schmerzen von Anfang an im Unterbauch oder sind sie von einem anderen Ort in den Unterbauch gewandert?** • Bekommen Sie Ihre Periode regelmäßig? • Wann war Ihre letzte Regelblutung/ Periode? ´ • Könnte es sein, dass Sie schwanger sind?	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine Blindarmentzündung.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Naomi Rosenthal. Sie **ist** 45 Jahre **alt, geboren** am 01.04.1971. Sie ist 1,61m groß und **wiegt** 59,9 kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit zwei bis drei Tagen bestehender Bauchschmerzen im rechten Unterbauch.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen vom periumbilikalen Bereich in den Unterbauch **ausgewandert sind**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen stechend, ziehend, persistierend und progredient.

Die Schmerzintensität liegt bei 8/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung**, während sie sich** in Ruhe **bessern.**

Außerdem erwähnt sie , dass sie gestern zur Untersuchung beim Hausarzt war, jedoch ohne auffällige Ergebnisse.

Begleitend klagt sie über Fieber (gestern Abend 38,8 °C, heute Morgen 39,9 °C), Übelkeit seit gestern Abend, Erbrechen heute Morgen zweimal, gelblich, Durchfall heute Morgen einmal, wässrig und braun, sowie Inappetenz seit gestern Abend.
Vegetativanamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Insomnie, Müdigkeit und Hyperhidrose.
Des Weiteren hat sie eine unregelmäßige Menstruation**.** Ihre letzte Periode war vor 40 Tagen.

An Vorerkrankungen leidet sie an einer Hypothyreose seit 10 Jahren sowie **an** Kopfschmerzen

An Operationen ist eine Tonsillektomie (vor 10 Jahren **bekannt.** Vermutlich ist damals eine Sepsis entstanden. Deshalb musste sie mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.

Der Patient nimmt L-Thyroxin 100 µg und Ibuprofen 400 mg **ein.**

Die Allergieanamnese war unauffällig.

Bei der Noxenanamnese erwähnte er 2-3 Gläser Wein am Wochenende. 2 mal pro Woche Ampfetamin.

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt **beim Vater** und eine Knieoperation **bei der Mutter.**

Sozialanamnestisch ist sie im IT-Bereich tätig, **ledig** und in einer homosexuellen Beziehung. Sie **hat** keine Kinder.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Appendizitis. **Dafür sprechen** die wandernden Bauchschmerzen von periumbilikal in den Unterbauch, Fieber, Übelkeit und Inappedenz.

Differentialdiagnostisch kommen eine Urolithiasis, Morbus Crohn (vielleicht erster Schub), Extrauteringravidität(homosexuelle Beziehung ?!), Adnexitis oder Ovarialtorsion in Betracht.

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.** *(Bei der körperlichen Untersuchung suche ich nach positivem McBurney-Punkt, positivem Lanz-Punkt und positivem Blumberg-Zeichen)*

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, **Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte** ,β-HCG, Elektrolyte, einen Urinstatus sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich ein Sono-Abdomen durchführen, ein Röntgen-Abdomen sowie ggf. ein CT-Abdomen **veranlassen.**

Ich werde ein chirurgisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen. **Als initiale Therapie** würde ich Nahrungskarenz, Flüssigkeitszufuhr sowie Analgetikum (z. B. Metamizol), Antiemetikum und Antibiotikum (z. B. Ceftriaxon und Metronidazol) verordnen. **Als kausale Therapie** kommt eine laparoskopische Appendektomie in Betracht.

3. Akute Gastroenteritis

İçindekilere dön

• Könnte es sein, dass das Essen verdorben war? • **Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?** • Haben Sie Sodbrennen, saures Aufstoßen, bitteren Geschmack im Mund ? • **Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt?**	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Magen-Darm-Entzündung**.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.Zunähcst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und eine Bauchultraschall durchführen.. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Maria Stettner. **Sie ist** 62 Jahre alt, **geboren am** 01.03.1964. **Sie ist** 1,67m groß und wiegt 69,5kg.

Sie **kam heute zu uns wegen seit** gestern Abend bestehender Schmerzen im Oberbauch.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach dem Verzehr von Mettbrötchen und Tramisu langsam **aufgetreten**.

Sie berichtet, dass die Schmerzen nirgendwohin **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen kolikartig, wellenförmig, persistierend und diffus**.**

Schmerzintensität liegt bei 5/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung, während sie sich **nach Erbrechen bessern**.

Begleitend klagt sie über Fieber (heute Morgen 38, °C axillär), **Übelkeit und dreimaliges Erbrechen**, das gelblich, schleimig, breiig und mit unverdautem Essen war.

Sie hatte **fünfmal Durchfall seit heute Morgen**, wässrig, schaumig, zunächst **hellrot**, jetzt **dunkelrot**.

Vegetativanamnestisch ergaben sich stressbedingte Insomnie, Inappetenz, Müdigkeit
Die gynäkologische Anamnese war unauffällig.

An Vorerkrankungen leidet sie an Kopfschmerzen, **Reizmagen** und **Raucherhusten**.

Sie hatte keine Operationen. Bei der Geburt ihrer Tochter wurde jedoch eine Vakuumextraktion durchgeführt.

Die Patientin nimmt bei Bedarf **ASS 500 mg, Baldrian, Maloxon ein.**

Sie hat Amoxicillinallergie**, die sich durch anaphylaktischen Schock äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie **täglich 10 Zigaretten seit dem 16. Lebensjahr** sowie **2 Gläser Wein am Wochenende**

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt beim Vater, daran gestorben, sowie **Brustkrebs bei der Mutter**, daran gestorben.

Sozialanamnestisch ist sie Taxifahrerin von Beruf, **geschieden** und wohnt **allein**.
Sie hat eine **Tochter**, die **drogenabhängig ist** und sich derzeit im **Methadon-Programm** befindet.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine akute Gastroenteritis **.**
Dafür sprechen der akute Beginn nach dem Verzehr von rohen tierischen Produkten, die progredienten kolikartigen Bauchschmerzen, das Erbrechen und der blutige Durchfall

Differentialdiagnostisch kommen **akute Pankreatitis, Ulcus ventrikuli und ACS** in Betracht.

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.**

Auserdem sollte ein EKG geschrieben werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, BZ, Herzmuskelenzyme, Lipase, Amylase sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT(Fecal occult Blood Test) und Stuhlkultur kontrollieren lassen.

Darüber hinaus werde ich eine Abdomen-Sonographie durchführen.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen und isolieren.

Ich würde Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution, magenschonende Ernährung (z.B.Kartoffeln, Reis und Apfel) Analgetika (z.B.Metamizol), Antiemetikum, Antipyretikum und Spasmolytika (Butylscopalamin) sowie Nikotinkarenz und Alkoholkarenz.

Nach Erregernachweiß kann ein Antibiotikum (Ciprofloxacin) eingesetzt werden.

4. Akute Pyelonephritis

İçindekilere dön

• Müssen Sie häufig Wasser lassen? • Wie ist Ihre Urinmenge? Viel oder wenig? • Müssen Sie nachts auf die Toilette? • Haben Sie Schmerzen oder brennendes Gefühl beim Wasserlassen? • Haben Sie Änderung der Urinfarbe/Harnfarbe bemerkt? • Haben Sie Blut im Urin bemerkt? • Haben Sie einen Ausfluss aus der Scheide bemerkt?	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine **Nierenentzündung.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Urinuntersuchung und einen Bauchultraschall durchführen.. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Gaby Wegner. Sie ist 59 Jahre alt, geboren am 01.04.1963. Sie ist 1,57m groß und wiegt 76,6 kg.

Frau Wegner kam heute zu uns wegen seit gestern Abend bestehender Schmerzen in der linken Flanke.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen beim Treppensteigen plötzlich **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen in den linken Unterbauch **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen klopfend, progredient, persistierend.

Die Schmerzintensität liegt bei 8/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung, **während** sie sich in Ruhe **bessern.**

Außerdem erwähnt sie, dass sie vor zwei Wochen ähnliche Beschwerden **hatte** und Cotrimoxazol für drei Tage **eingenommen hat.**

Begleitend klagt sie über Fieber (seit gestern 38,8 °C), Pollakisurie, Oligurie, Nykturie und Hämaturie (seit zwei Tagen)

Vegetativanamnestisch ergaben sich Diarrhoe (3–4×), schmerzbedingte Insomnie, Inappetenz.
Die gynäkologische Anamnese war unauffällig.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 5 Jahren **an** arterieller Hypertonie und **erlitt** eine Glomerulonephritis vor 40 Jahren.

An Operationen sind eine Tonsillektomie (im 10. Lebensjahr), eine Appendektomie (im 18. Lebensjahr) und Sectio caesarea (vor 25 Jahren) **bekannt.**

Der Patient nimmt Nebivolol 10 mg und Candesartan 4 mg **ein**.

Sie hat Nickel-und Braunesflaster **allergie, die sich durch** Pruritus und Erythem **äußern**.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie gelegentlich Wein und Sekt.

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt und arterielle Hypertonie **beim Vater.** Ihre Mutter litt an Glomerulonephritis, war dialysepflichtig und erhielt eine Nierentransplantation. Sie ist nach einer Herzoperation verstorben. Ihr Großvater hatte Ikterus.

Sozialanamnestisch ist sie Angestellte beim Einwohnermeldeamt, verheiratet und wohnt mit ihrem Mann zusammen. Sie hat eine Tochter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Pyelonephritis.
Dafür sprechen klopfende, persistierende Flankenschmerzen, Fieber, Pollakisurie, Dysurie, Nykturie, Oligurie und Hämaturie.

Differentialdiagnostisch kommen ein akuter Schub einer chronischen Glomerulonephritis, eine Urolithiasis, eine Divertikulitis und eine Adnexitis **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlisch zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, Blut für das Labor abnehmen.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Urinstatus, Urinkultur **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Nierensonographie durchführen und ein Urologisches Konsil sowie ein nephrologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen Ich würde symptomatisch Analgetikum, Antiemetikum, Spasmolytikum, Antipyretikum **sowie** Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstition **verordnen.**

Als kausale Therapie würde ich natürlich ein Antibiotikum, z. B. ein Fluorchinolon (Ciprofloxacin oder Levofloxacin) **beginnen.**

5. Asthma

İçindekilere dön

• Seit wann haben Sie Atemnot? • Ist die Atemnot plötzlich oder langsam aufgetreten? • **Ist sie dauerhaft vorhanden oder kommt sie in Attacken?** • **Treten die Beschwerden nur bei Belastung oder auch in Ruhe auf? (belastungsabhängig?)** • Wie lange dauert eine Attacke an? Wie oft kommt es zu einer Attacke? • In welcher Situation sind die Beschwerden aufgetreten? • Sind die Beschwerden abhängig davon, ob Sie stehen, sitzen oder liegen? (lageabhängig?)	• **Haben Sie während der Attacken pfeifende Atemgeräusche bemerkt?** • Sind Ihnen Giemen oder Brummen aufgefallen? • **Kann es einen Zusammenhang zwischen Ihrem Hund und Ihren Attacken geben?“** • Können Sie flach liegen oder brauchen Sie zum Schlafen mehrere Kissen – besonders nach einer Attacke? • **Tritt der Husten zu bestimmten Tageszeiten auf? (nachts, tagsüber)** • Könnten Sie den Husten genauer beschreiben? Ist er trocken, oder haben Sie Auswurf? • Gibt es Blut im Auswurf? • Treten Ihre Beschwerden **zu Hause,** bei **der Arbeit** oder an beiden Orten auf?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Asthma (wie Ihre Mutter), und vielleicht aufgrund Ihres neuen Hunds. Das kann zu Atmen Probleme, Husten, ein Engegefühl in der Brust führen. Ursachen können z. B. durch Allergien, Infekte, körperliche Belastung, kalte Luft sein .

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen Lungen-Röntgen **veranlassen. Dann werde ich *eine*** LuFu (Lungenfunktionsprüfung) und einen Prick-Hauttest **durchführen.**

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

LUFU (Lungenfunktionstest – Spirometrie)

Durch diese Untersuchung können wir die Lungenkapazität und Atmungsfunktion der Lungen beurteilen.

Dieses Verfahren ist einfach, praktisch, risikofrei und dauert etwa 5- 10 Minuten.

- Bei der Untersuchung würde Ihre Nase mit einer Nasenklemme verschlossen.
- **Sie sollten ein Mundstück mit beiden Lippen fest umschließen.**
- Dann atmen Sie ca. 5 bis 10 Minuten durch das Mundstück ein und aus.
- Gleichzeitig misst das Gerät die Luftmenge und stellt sie auf einem Bildschirm dar.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über meinen Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Herrn Popple Bach. **Er ist** 55 **Jahre alt, geboren am** 08.04.1971**. Er ist** 1,81m **groß und wiegt** 74.4 **kg.**

Er kam heute zu uns wegen heute Morgen aufgetretener Dyspnoe und trockenem Husten.

Laut Aussage des Patienten sind die Symptome plötzlich und attackenartig aufgetreten und dauern jeweils 10–15 Minuten.

Er berichtet, dass die Symptome belastungsunabhängig sind und spontan wieder verschwinden.

Er gab keinen klaren Auslöser **an**. Allerdings hat er kurz vor Beginn der Beschwerden einen Hund für seine Frau angeschajjt. **Bei der Allergieanamnese** ergab sich eine Allergie gegen Katzenhaare in der Kindheit.

Die Symptome verschlimmern sich nachts und in den frühen Morgenstunden, **während sie sich bei** der Arbeit oder an der frischen Luft **bessern.**

Außerdem erwähnt er, dass sie seit drei Wochen **ähnliche Beschwerden hatte**.

Vegetativanamnestisch ergab sich Dysomnie wegen der nächtlichen Atemnotattaken

An Vorerkrankungen leidet er unter Bauchschmerzen und Diarrhö bei Stress (V.a. RDS) sowie **an** einem Zustand nach Hepatitis A.

An Operationen sind eine Tonsillektomie (im 7. Lebensjahr) und eine Appendektomie (im 20. Lebensjahr) **bekannt**.

Der Patient nimmt Kijimea b.B. **ein.**

Bei der Noxenanamnese erwähnt er 1 -2 Gläser Rotwein pro Woche

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom Myokardinfarkt **beim Vater**(vor einem Jahr daran verstorben) Asthma **bei der Mutter** und einen Verdacht auf Nierenversagen **beim Bruder,** der dialysepflichtig ist.

Sozialanamnestisch ist er im IT-Bereich tätig, verheiratet und hat keine Kinder.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein **allergisches Asthma**. **Dafür sprechen** Paroxysmale Dyspnoe, trockener Husten, eine Allergie gegen Katzenhaare in der Kindheit, eine familiäre Belastung und das Auftreten der Beschwerden nach Anschaffung eines Labradors.

Differentialdiagnostisch kommen eine Pneumonie und Bronchialkarzinom **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der Auskultation suche ich nach pfeifenden Atemgeräuschen. **Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.**

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, BGA, gesamt- Ig E **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Spirometrie mit Reversibilitätstest, einen Prick-Hauttest und eine Röntgen-Thorax-Aufnahme **durchführen**

Zudem werde ich ein pulmonologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten ambulant behandeln.
Allergenkarenz wird empfohlen.
Je nach Stufentherapie sollte er zu Beginn niedrig dosierte inhalative Kortikosteroide (z. B. Fluticason) als Dauermedikation sowie ein kurzwirksames β2-Sympathomimetikum (Salbutamol) als Bedarfsmedikation **erhalten.**

6. Burn Out

İçindekilere dön

- War Ihnen schwindelig oder wurde Ihnen „schwarz vor Augen“?
- Gibt es ein Auslösender für den Schwindel? z.B. beim Aufstehen, beim Drehen des Kopfs oder in Ruhe?(hitzekollaps)
- Wie können Sie Ihr Schwindel beschreiben? Wie in einem Karussell oder in einem Boot?
- Wie lange dauert eine Attacke?
- Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen,Taubheitsgefühl, Krebbelngefühl haben?
- Haben Sie Sehstörungen oder Hörstörungen?
- Haben Sie weniger Kraft in einer bestimmten Körperregion bemerkt?
- Ist Ihr Blutdruckt medikamentös gut eingestellt?
- Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Blutdruck gemessen?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht **auf Burn-out-Syndrom(oder nicht unkontrollierte Bluthochdruck), möglicherweise aufgrund Ihres anhaltenden Stresses. Das Burn-out-Syndrom bedeutet, dass man durch langen Stress völlig erschöpft ist und keine Energie mehr hat**.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen Ultraschall der Schilddrüse durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von

168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Henrike Meyer. Sie ist 63 Jahre alt, geboren am 10.02.1962. Sie ist 1,76m groß und wiegt 95kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit einer Stunde bestehendem Schwindel.

Laut Aussage der Patientin sind der Schwindel plötzlich beim Spazierengang **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass der Schwindel seit 2-3 Jahren besteht, zusätzlich anfallartig auftritt.

Nach Angaben der Patientin sind die Schwindelattacken in der letzten Zeit häufiger geworden.

Außerdem erwähnt sie , dass die Patienten vor einem Jahr beim Hausarzt war , jedoch ohne auffällige Befunde.

Begleitend klagt sie über Übelkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Die Fragen nach neurologischen Syptomen wurden verneint.

Vegetativanamnestisch ergaben sich Inappetenz, Verstopfung seit mehreren Jahren, Nykturie (1–2 Mal pro Nacht) und Insomnie.

Des Weiteren ist sie seit x Jahnren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 15 Jahren an arterieller Hypertonie, seit mehreren Jahren an rezidivierenden Kopfschmerzen. (bei unkontrolierter Hipertonie ; ***Sie weiß nicht, ob ihr Blutdruck gut eingestellt ist, weil sie ihn seit einem Monat nicht gemessen hat. Das letzte Mal war ihr Blutdruck bei 150/90 mmHg.***

An Operationen sind eine Tonsilllektomi (vor 8 Jahren) , eine Appendektomi (vor 13 Jahren) und eine Hysterektomie (vor 8 Jahren) **bekannt.**

Die Patientin nimmt Beloc-Zok® 47,5 mg 1-0-1, Amlodipin 5mg 1-0-1 **ein**.

Sie hat Allergien gegen Nickel und Braunpflaster, **die sich durch** Pruritus und Exanthem **äußern**.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie einen Nikotinkonsum von 20 Packyears bis vor 5 Jahren **sowie den Konsum von** einer Flasche Bier am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab einen Apoplex **beim Vater**, DM Typ 2 **bei der Mutter** und pAVK **beim Bruder.**

Sozialanamnestisch ist sie verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat keine Kinder. Sie ist Bäckerin von Beruf und berichtet über viel Stress bei der Arbeit und zu Hause.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein **Burn-out-Syndrom. Dafür sprechen** Anhaltender Stress, körperliche und geistige Erschöpfung, Kopfschmerzen, rezidivierende Schwindelattacken, Insomnie sowie Inappetenz.

Differentialdiagnostisch kommen eine Anämie, eine unkontrollierte Hypertonieattacke sowie eine Hypothyreose **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, Blut für das Labor abnehmen.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte , TSH, fT3, fT4 , Ferritin, Transferrin, Vitamin B12 und Folsäure **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich ein Sono-Throidea und eine Duplexsonographie der Halsgefäße durchführen sowie ggf. ein CT-Schädel veranlassen.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin ambulant behandeln.

- ✓ Eine **Patientenschulung** zur Stressbewältigung und Selbstfürsorge wird empfohlen.
- ✓ Eine **Lebensstilveränderung** (ausreichender Schlaf, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Reduktion der Arbeitsbelastung) spielt eine große Rolle.
- ✓ **Ich werde** auch ein psycholo**gisches Konsil** zur weiteren Unterstützung **anfordern.**
- ✓ **Ich werde** auch ein **kardiologisches Konsil** zur weiteren Therapioptimierung **anfordern.**

7. Choledocholithiasis

İçindekilere dön

• Haben Sie bestimmte Lebensmittel bemerkt, die Ihre Beschwerden verschlimmern, beispielsweise fettreiche Mahlzeiten? • Haben Sie Veränderungen in Ihrer Verdauung bemerkt, wie z.B. Blähungen, Durchfall oder Verstopfung? • Haben Sie eine Veränderung der Stuhlfarbe bemerkt? • Ist Ihnen eine Veränderung der Urinfarbe aufgefallen?	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Galensteinleiden. Wahrscheinlich haben Sie in der Gallenblase oder in den Gallenwegen Steine, die diese Beschwerden verursachen.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen Bauchultraschall durchführen.Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Rose -Marie Hagen. **Sie ist** 57 **Jahre alt, geboren am** 01.01.1963**. Sie ist 1,65 m groß und wiegt 71 kg**.

Sie **kam heute zu uns wegen seit** 2 Stunden bestehender, starker Schmerzen im rechten Oberbauch.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich postprandial (nach dem Verzehr von Makrelen-Röllchen) **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen in die rechte Schulter **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen kolikartig und stechend.

Schmerzintensität liegt bei 8/10 **auf der NRS.**

Außerdem erwähnt sie, dass sie seit 2–3 Wochen ähnliche Beschwerden **hat,** aber die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer geworden sind.
Begleitend klagt sie über Übelkeit seit einer Woche, Erbrechen seit heute Morgen dreimal, mit Speisereste und Galle.
Darüber hinaus hat sie seit einer Woche wässrigen, hellbraunen Durchfall sowie dunklen Urin

Vegetativanamnestisch ergaben sich Müdigkeit, schmerzbedingte Insomnie, Inappetenz.

In der gynäkologischen Anamnese berichtet die Patientin, dass ihre Periode unregelmäßig **ist.** Die letzte Periode war vor 15 Tagen.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 10 Jahren an Hypothyreose.

An Operationen sind eine Tonsillektomie im 10. Lebensjahr, eine transvaginaler Hysterektomie vor 3 Jahren **bekannt.**

Die Patientin nimmt L-Thyroxin 100 mikrogram**,** Magnesium unklare Dosis (1-0-0), ASS 100 mg (1-0-0) seit 30 Jahren, Venoruton 300 mg (1-0-0) **ein.**
Sie hat eine Nickel**allergie, die sich durch** Pruritus und Erythem **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie zwei Gläser Wein oder Champagner am Wochenende.
Die Familienanamnese ergab Apoplex und Herpes zoster **beim Vater sowie** MI, DM Typ II und Adipositas **bei der Mutter**. Sie ist mit 65 L. J. plötzlich verstorben.

Sozialanamnestisch ist sie Managerin ihres Mannes, verheiratet und hat zwei Töchter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Choledocholithiasis.
Dafür sprechen die kolikartigen rechtsseitigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die rechte Schulter, dunkler Urin, Übelkeit, Erbrechen und heller Stuhl.

Differentialdiagnostisch kommen akute Pankreatitis, Ulcus ventriculi **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlisch zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen , Blut für das Labor abnehmen.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte ,Cholestaseparameter, Lipase, Amylase, Herzenzyme, Lipidprofil, ggf. einen Urinstatus sowie ggf. eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) **kontrollieren lassen.**

Des Weiteren werde ich Sono-abdomen **durchführen und ein** gastroenterologisches sowie ein chirurgisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich die Patientin stationär **aufnehmen**. **Als initiale Therapie würde ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution,** magenschonende Ernährung, Nikotinkarenz, Alkoholkarenz sowie symptomatisch ein Analgetikums (z. B. Metamizol) und ein Antiemetikum, Spasmolytikum **verordnen.** Je nach Befunde kann ein ERCP erforderlich sein.

Die Steingröße spielt eine wichtige Rolle bei der Therapieentscheidung.

Bei Choledochussteinen ≥ 10 mm ist eine ERCP in der Regel indiziert, da ein spontaner Abgang unwahrscheinlich ist.

Für eine medikamentöse Auflösung in der Gallenblase kommen meist nur kleine, nicht verkalkte Steine ≤ 5–10 mm in Frage; größere Steine werden eher operativ behandelt.

Die medikamentöse Steinauflösung mit UDCA wird nur bei Gallenblasensteinen eingesetzt. Bei Choledochussteinen ist sie nicht geeignet; hier ist eine ERCP mit Steinextraktion die Therapie der Wahl.

8. Divertikülitis

İçindekilere dön

• **Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt?** • **Wann war Ihr letzter Stuhlgang?** • **Können Sie Winde ablassen?** • **Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?** • **Leiden Sie schon länger unter Verstopfung?** • **Ist das Blut eher hellrot oder dunkel** • **Wechseln sich bei Ihnen Durchfall und Verstopfung ab?**	• **Wie ernähren Sie sich ? Worauf achten Sie ?** • **Haben Sie Schmerzen oder ein Brennen beim Wasserlassen?** • **Müssen Sie häufiger Wasser lassen als sonst?** • **Müssen Sie nachts öfter auf die Toilette?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine **Entzündung von kleinen Ausstülpungen im Dickdarm. Das bedeutet, dass sich kleine Ausstülpungen im Dickdarm entzündet haben**. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.

Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Ulrike Dohmen. **Sie ist** 65 Jahre alt, **geboren am** 26.11.1961. **Sie ist** 1,56m groß und wiegt 85kg.

Frau Wegner **kam heute zu uns wegen seit** gestern Abend bestehender Schmerzen im linken Unterbauch.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen in den mittleren Unterbauch **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen drückend, progredient, persistierend.

Schmerzintensität liegt bei 5/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung und beim Stuhlgang**.**

Außerdem erwähnt sie, dass sie als sie jung war, **änliche Beschwerden hatte**. Damals wurde bei ihr eine Apendektomie durchgeführt.

Begleitend klagt sie über Fieber (seit gestern 38,8 °C), Obstipation, Hämatochezie, Pollakisurie und Nykturie

Vegetativanamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Insomnie, Inappetenz.
Die gynäkologische Anamnese war unauffällig.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 2 Jahren **an** arterielle Hypertonie.

An Operationen ist eine Appendektomie im 22. Lebensjahr **bekannt.**

Die Patientin nimmt regelmäßig morgens einmal Ramipril 5 mg und bei Bedarf Abführkapseln **ein.**

Sie hat Narkose-und Laktoseintolereanz**, die sich durch** Blähungen und Bauchschmerzen **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte er gelegentlich ein Glas Wein.

Die Familienanamnese ergab DM Type 2 **beim Vater** (er ist vermutlich an einer Komplikation des Diabetes verstorben.) sowie Altersswäche **bei der Mutter**.

Sozialanamnestisch ist sie seit einem Jahr im Ruhestand. Vorher Sekretärin beim Standesamt, ledig, hat keine Kinder.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine **Divertiklutis .**
Beschwerden wie linksseitige Unterbauchschmerzen, Fieber, Obstipation und Hämatochezie sprechen für eine akute Divertikulitis

Differentialdiagnostisch kommen **ein Kolonkarzinom** und **ein Harnwegsinfekt** in Betracht.

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Suthluntersuchung, Urinstatus, Urinkultur kontrollieren lassen.

Darüber hinaus werde ich eine Abdomen-Sonographie durchführen. Ggf werde ich ein Abdomen CT mit KM veranlassen.

Ich werde ein **chirurgisches Konsil** anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen.

Ich würde Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution sowie Analgetikum (z. B. Metamizol), Antipyretikum und eine Antibiotikatherapie (Ceftriakson mit Metronidazol) **verordnen**. Auch Nahrungskarenz oder leichte Kost.

Ich würde auch **Ballaststoffreiche Ernährung** (z. B. Vollkornprodukte, Gemüse, Obst) , Ausreichende **Flüssigkeitszufuhr** (ca. 1,5–2 Liter täglich, sofern keine Kontraindikation besteht) , Vermeidung von **Obstipation**, Regelmäßige **körperliche Aktivität** (z. B. tägliches Gehen, Bewegung zur Förderung der Darmmotilität), Gewichtsreduktion bei **Adipositas** (falls vorhanden), Stressreduktion, Regelmäßige ärztliche Kontrolle bei rezidivierenden Beschwerden **empfehlen.**

9. Entgleister DM

İçindekilere dön

- Haben Sie sich am Kopf verletzt?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen oder Kraftverlust haben?
- Haben Sie Kribbelgefühle oder Taubheitsgefühle bemerkt?
- Leiden Sie unter Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen?
- Sind Sie lichtempfindlichkeit oder larmenpfindlichkeit?
- Haben Sie Schwindel?
- Müssen Sie häufig Wasser lassen? Pollakisurie
- Müssen Sie nachts auf die Toilette gehen? Nykturie
- Haben Sie verstarkten Durst bemerkt? Wie viel Wasser trinken Sie taglich?
- Haben Sie Brustschmerzen, ein Engegefühl oder Drückgefühl in der Brust?

- **Messen Sie regelmäßig Ihren Blutzucker und Blutdruck? Wann haben Sie zuletzt Ihren Blutdruck gemessen? Können Sie mir das Ergebnis sagen?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Komplikationen durch Ihre Zuckerkrankheit und Ihren Bluthochdruck. **Das bedeutet**, dass Ihr Blutzuckerspiegel erhöht ist und Ihr Körper den Zucker nicht mehr richtig verarbeiten kann. **Das kann zu** starker Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen **führen**.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunähcst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werden wir möglicherweise Ihre Zuckerkrankheit- und Blutdruckmedikamente anpassen. Wir werden Ihnen die richtige Behandlung geben, um Ihre Beschwerden zu lindern.

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Silvia Hammers**. Sie ist 63** Jahre alt, **geboren am** 24.12.1957. **Sie ist** 1,87m **groß und wiegt** 89,8 **kg**.

Die Patientin mit bekannten Diagnosen einer Hypertonie und eines Diabetes mellitus Typ 2 **kam heute zu uns wegen seit drei Tagen bestehender Kopfschmerzen im Temporalbereich sowie seit gestern Abend plötzlich aufgetretenen beidseitigen Flimmerns ohne Sehminderung.**

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen langsam **aufgetreten** und im Laufe der Zeit schlimmer geworden.
Sie berichtet, dass die Schmerzen nirgendwohin **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen klopfend, pulsierend und persistierend**.**

Die Schmerzintensität liegt morgens bei 6/10 und abends bei 8/10 **auf der NRS**.

Die Schmerzen verschlimmern sich abends und bei der Arbeit wegen Stress. Sie hat Ibuprofen 600 mg eingenommen, jedoch ohne Besserung.

Außerdem hat sie seit längerer Zeit rezidivierende, beidseitige drückende Kopfschmerzen hat.

Begleitend klagt sie über Übelkeit, Vertigo, Tachykardie, Polydipsie, und Pollakisurie**.**

Vegetativ-anamnestisch ergab sich schmerzbedingte Insomnie.

Sie ist seit 10 Jahren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie an einer arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, die nicht gut eingestellt ist. Die letzte Blutdruckmessung war heute Morgen: 180/90 mmHg. Zudem leidet sie an Diabetes mellitus Typ II seit 8 Jahren, der nicht gut kontrolliert ist. Seit 2 Wochen sind ihre Teststreifen ausgegangen, weshalb sie den Blutzucker nicht messen konnte. Die letzte Messung vor 2 Wochen war erhöht.

An Operationen ist eine Cholezystektomie vor 10 Jahren **bekannt.**

Die Patientin nimmt Metformin 850 mg, Ramipril 5 mg ,Magnesium in unklarer Dosierung sowie Ibuprofen bei Bedarf **ein**.

Sie hat eine Penicillin**allergie, die sich durch** Exanthem und Pruritus **äußert.**

Bei der Noxenanamnese berichtere er über den Konsum von zwei Gläsern Wein oder Prosecco alle zwei Wochen.

Die Familienanamnese ergab Pneumokoniose **beim Vater**, Gonarthrose **bei der Mutter sowie** Myokardinfarkt **bei der Schwester**, an dem sie verstorben ist.

Sozialanamnestisch ist sie Betriebsbuchhalterin von Beruf, verheiratet, lebt mit ihrem Mann und hat zwei gesunde Töchter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine **Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie. Dafür sprechen** die Kopfschmerzen, Vertigo, Photopsien, die Vorgeschichte mit aHT und DM Typ II, der hohe Blutdruck heute Morgen sowie der zuletzt erhöhte Blutzuckerwert und die fehlende Blutzuckerkontrolle seit 2 Wochen

Differentialdiagnostisch kommen Migräne,TIA und Spannungskopfschmerzen **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen .

Anschließend werde ich die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.

Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden, um Herzrrhtmusstörungen auszuschließen

Im Labor würde ich Blutbild, BZ, HbA1c, Ketonkörper im Blut und Urin, BGA, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Lipidprofil und Urinstatus bestimmen lassen.

Darüber hinaus werde ich eine Langzeitblutdruckmessung sowie ein CT-Schädel veranlassen.

Ich werde ein endokrinologisches Konsil anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen.

Als initiale Therapie würde ich eine Infusionstherapie (Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution) sowie eine symptomatische Behandlung **verordnen**.

Die Medikamente wie Antihypertensivum und Antidiabetika **sollen angepasst werden.**
Eine Ernährungsumstellung und Lebensstilveränderungen werden empfohlen.

10. GERD

İçindekilere dön

- **Haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?**
- **Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?**
- **Haben Sie Sodbrennen, sauren Geschmack, saures Aufstoßen?**
- **Haben Sie Schluckbeschwerden?**
- **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Heiserkeit, Globusgefühl im Hals haben?**
- **Haben Sie Husten?**
- **Wann trit der Husten auf?**
- **Gibst es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? z.B. eine bestimmte Körperlage wie Rückenlage, Bücken, Pressen ?**
- **Wie viele Kissen benutzen Sie beim Schlafen?**
- **Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Beschwerden hat?**
- **WO haben Sie gegessen?**
- **MIT wem haben Sie das gegessen?**
- **Könnte es sein, dass das Essen verdroben ist?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine **Refluxkrankheit**. ***Das heißt, dass Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt und dort Reizungen,Entzündungen, Schmerzen oder Sodbrennen verursachen kann***.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen .Danach werde ich einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen. Darüber hinaus werde ich einen Bauchultraschall durchfüren. Bei Ihnen kann eine Magenspiegelung durchgeführt werden.

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Wissen Sie, was das ist?Haben Sie an mich noch Fragen?

Magenspiegelung / ÖGD:

Die Magenspiegelung ist eine Untersuchung, mit der wir die hohlen Organe in Ihrem Körper beobachten können. Dazu führen wir einen Schlauch mit einer Kamera durch den Mund ein. Wir geben Ihnen ein Beruhigungsmittel, damit Sie nichts spüren. Wir können auch einige Gewebeproben (Biopsien) entnehmen, damit können wir eine Diagnose stellen.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Renta Cordes**. Sie ist 67** Jahre alt, **geboren am** 02.02.1959. **Sie ist** 1,67m **groß und wiegt** 82,5 **kg**.

Sie kam heute zu uns wegen gestern Abend plötzlich aufgetretener, retrosternaler Schmerzen.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach dem Essen von Bratwurst aufgetreten und nach einer Stunde selbst weggegangen. Momentan hat sie keine Schmerzen. **Sie berichtet, dass die Schmerzen** in den Hals **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen brennend und wellenförmig **.**

Die Schmerzintensität liegt bei 5-6/10 **auf der NRS**.

Die Schmerzen verschlimmern sich beim Hinlegen nach dem Essen, während sie sich bei der **Oberkörperhochlagerung** mit **zwei Kissen** bessern.

Außerdem erwähnte sie , dass sie seit 6 Wochen ähnliche, aber leichtere Beschwerden hat. Die Schmerzattacken haben ca. eine Stunde angedauert.

Begleitend klagt sie über Übelkeit, Sodbrennen, Aufstoßen und bitteren Geschmack im Mund**.**

Vegetativanamnestisch ergaben sich Inappetenz und schmerzbedingte Dysomnie.

Sie ist seit 12 Jahren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren. Die letzte Blutdruckmessung war heute Morgen: 130/80 mmHg.

An Operationen ist eine Plattenosteosynthese vor 10 Jahren **bekannt.**
Die Patientin nimmt Amlodipin 10 mg, Ramipril 5 mg **ein**.
Sie hat eine Pollen**allergie, die sich durch** Rhinitis **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie einen Nikotinkonsum von 7,5 py **sowie** 2 Gläsern Altbier **täglich.**

Die Familienanamnese ergab Ösophaguskarzinom **beim Vater**, an dem er verstorben ist, Apoplex, Dm Typ 2 und aHT **bei der Mutter sowie** Depression **bei der Schwester**.

Sozialanamnestisch ist sie Rentnerin. Früher war sie Zugbegleiterin, verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat eine Tochter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine **Gastroösophageale Refluxkrankheit. Dafür sprechen** die attackenartigen, brennenden, in den Hals ausstrahlenden, retrosternalen Schmerzen, Sodbrennen, saurer Geschmack im Mund, beim Hinlegen Veschlimmerung.

Differentialdiagnostisch kommen ACS und Ösophaguskarzinom **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen**.

Außerdem sollte ein EKG geschrieben werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Herzmuskelsenzyme, Lipidprofil, Stuhluntersuchung+FOBT (fäkaller okkuler Bluttest) **bestimmen lassen.**

Darüber hinaus werde ich Sono-abdomen **durchführen** , ggf. ÖGD oder langzeit-ph-Metrie **veranlassen.**

Ich werde ein gastroentero**logisches Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin ambulant behandeln.

Ich empfehle der Patientin, den Lebensstil zu ändern, Gewichts abzunehmen, magenschonende Ernährung zu beachten, spätes Essen am Abend zu vermeiden und enge Kleidung zu vermeiden.

Ich würde medikamentös PPI und Antazida verordnen.

Alkoholkarenz wird empfohlen.

11. HWS

İçindekilere dön

- Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Fehlbewegungen, Hebetrauma oder Kälteexposition?
  Haben Sie sich am Kopf verletzt?
- Haben Sie Schwindel oder Bewusstsein verloren?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen oder Kraftverlust haben?
- Haben Sie Kribbel oder Taubheitsgefühle bemerkt?
- Leiden Sie unter Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen?
- Haben Sie in letzter Zeit etwas Schweres gehoben?
- Was machen Sie beruflich?
- Arbeiten Sie viel am Computer?
- Sind Sie Rechts- oder Linkshänder?
- Wie ist Ihre Körperhaltung bei der Arbeit?
- Haben Sie Nackenschmerzen oder Muskelverspannungen bemerkt?
- Treiben Sie regelmäßig Sport?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **eine Muskelverspannung im Nackenbereich**. ***Das ist eine schmerzhafte Verspannung und Funktionsstörung im Nackenbereich. Es kommt oft von Fehlhaltung, oder langem Sitzen. Die Wirbelsäule ist nicht verletzt, aber die Muskeln und Gelenke sind überlastet. Das kann zu Nacken- und Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, manchmal auch zu Schwindel oder Kribbeln in den Armen führen.***

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen, Danach machen wir einen EKG, um eine Herzursache auszuschließen. Dann werden wir eine Röntgenaufnahme Ihres Halses veranlassen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen

Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Herrn Andreas Scholten**. Er ist** 33 Jahre alt, **geboren am** 08.09.1993. **Er ist** 1,75m **groß und wiegt** 72,3 kg.

Er kam heute zu uns wegen seit 4 Tagen bestehender linksseitiger Schmerzen im Nacken und Hinterkopf .

Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen langsam **aufgetreten** und im Laufe der Zeit schlimmer geworden.
Er berichtet, dass die Schmerzen in den linken Arm und in die linke Schulter **ausstrahlen.**

Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen ziehend, brennend, drückend und bewegungsabhängig .

Die Schmerzintensität liegt bei 7-8/10 auf der NRS.

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung, währed sie sich mit einer Wärmekompreese teilweise **besern.**

Außerdem hat er ähnliche Beschwerden vor einem Monat. Damals waren Ibuprofen und Wärnmekissen hilfreich.

Begleitend klagt er seit gestern **über** schmerzbedingte Insomnie, Inappetenz, Übelkeit und Parästhesien im linken Arm.

Vegetativeanamnestisch ergab sich lediglich Kaltschweißigkeit

An Vorerkrankungen leidet er Tinnutus seit 14 Jahren, beidseitig, sowie leichte Kopfschmerzen im gesamten Kopf etwa 1-2 Mal pro Monat.

An Operationen ist eine Osteosynthese (wegen einer linken Unterarmfraktur) **bekannt.**

Der Patient nimmt Ibuprofen b.B. gegen Kopfschmerzen **ein**.

In der Kindheit hatte er Pollenallergie, die mit einer Eigenbluttherapie behandelt wurde.

Bei der Noxenanamnese erwähnte er täglich 3-4 Zigaretten seit 5 Jahren und 2-3 Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt **beim Vater**,(an dem er im Alter von 55 Jahren verstoren ist), **sowie** eine arterielle Hypertonie **bei der Mutter.**

Sozialanamnestisch ist er ledig, **lebt** mit seiner Freundin zusammen und **hat** keine Kinder**. Er ist** Angestellter im Einwohnermeldeamt**, arbeitet t**äglich 8 Stunden am Computer, benutzt überwiegend die linke Hand.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf funktionelles HWS-Syndrom. **Dafür sprechen** Kopschmerzen, Nackenschmerzen, Parästhesien am linken Arm sowie taglich 8 Stunden Bildschirmarbeit

Differentialdiagnostisch kommen ACS, ein dejeneratives HWS-Syndrom und (HWS-Bandscheibenvorfall) **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf die Sensibilität, die Reflexe und die Muskelkraft. Zudem werde ich **Blut für das Labor abnehmen**.

Im Labor würde ich BB, Entzündungsparameter, Elektrolyte , Nierenwerte und Leberwerte, Herzmuskelenzyme und bestimmen lassen.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache abzuklären**.**

Darüber hinaus werde ich eine zervikale Röntgenaufnahme in 2 Ebenen(posterior-anterior und latero-lateral) und ggf. zervikale MRT veranlassen.

Ich werde ein orthopädisches Konsil anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich ihn ambulant **behandeln.**

Als initiale Therapie würde ich Analgetika (z.B.Metamizol) und Muskelrelaxantien (Tolperison, Methocarbamol, Tizanidin, Baclofen) **verordnen**.

Außerdem empfehle ich als kausal Therapie Physiotherapie (Krankengymnastik) und die Patientenschulung (Fehlhaltungen zu vermeiden, mehr Bewegung, Studenlangs Sitzen zu vermeiden)

♂ Doğru ergonomik duruş için öneriler (kısa ve anlaşılır)

Achten Sie darauf, aufrecht zu sitzen, die Schultern entspannt zu halten, beide Füße auf dem Boden zu lassen, Hüfte und Knie im 90-Grad-Winkel zu halten, den Bildschirm auf Augenhöhe zu positionieren, Tastatur und Maus nah am Körper zu benutzen und alle 45–60 Minuten eine kurze Pause mit Dehnübungen einzulegen. So entlasten Sie die Hals- und Rückenmuskulatur.

Wie diagnostiziert man das Karpaltunnelsyndrom klinisch? Fragen Sie nach den Symptomen, wie Schmerzen, Taubheit (Hypästhesie) oder Kribbeln (Parästhesie) in der Hand, insbesondere in den ersten drei Fingern. Diese Symptome treten oft nachts auf oder bei bestimmten Handbewegungen. Ein Elektromyogramm (EMG) wird durchgeführt, um die Diagnose zu bestätigen. (Median nerve)

Welche Abteilung ist dafür verantwortlich, die Büromöbel zu wechseln, wenn sie gesundheitliche Probleme bei den Mitarbeitern verursachen?.....

Anämie: Was könnte die Ursache sein? Blutung, MDS, Leukemie, Thalassämie.

Sie gehen zum Patienten, was machen Sie als Erstes? Ich überprüfe, ob der Patient noch lebt und vital misst. KU insbesondere Neurologische Untersuchung (Hirnnerven, Ophthalmoskopie, Reflexe, Kraft, Muskeltonus, Sensibilität und Meningismus Zeichen prüfen)

Warum röntgen, Was erwarten Sie vom Röntgen? Erhöhte zervikale Lordose, Frakturen, Osteophyten, **T**umoren oder Metastasen. **Was bedeutet Insomnie?** Schlafstörungen.

HbA1c ~ 8.3%, Glykose ~185, Leuk 12.000, CRP: 8.3. Ich habe direkt gesagt, dass der Patient Typ-2-Diabetes hat. Wunderbar

Unterschied zwischen DM1 und DM2? was bedeutet funkt. HWS? Meningitis im Umgangssprach?

BMI zu rechnen u. Was noch: Die Med. zu Dosieren war er zufrieden, VD? DD? Warum ACS (Familiäre Belastung), **warum keine Meningitis (Meningismus neg.) Wie untersuche ich Pat. Mit Verdacht auf Meningitis: Prüfung der Nackesteifigkeit, was ist die Fachausdrück? Meningismus**

Was ist Läuse u. Mäuse? Wusste ich nicht, er meinte mein Pat. hat 2 Erklärungen (HWS +DM) letzte Frage, was ist **Pylorusspamus? Pylorusstenose**, Symptome? **Schwalartiger Erbrechen,** wie sieht das Erbrochene? wusste ich nicht, er meinte: **die Muttermilch**

Das ist ein Syndrom!!! Genaue Beschreibung, welche Strukturen betroffen sein könnten. Was spricht dafür? Büroarbeit (im Einwohnermeldeamt)

Diagnostik für jede mögliche Strukturveränderung. **Zervikaler Bandscheibenvorfall selten. Diskus intervertebralia = Bandscheibe.**

Was ist wichtig bei der körperlichen Untersuchung: Sensibilität, Kraft der Kernmuskeln, Muskeleigenreflexe, Meningitis-Zeichen.

Welche Reflexe? Wichtig ist die Familienanamnese, da die Oma und die Schwester des Patienten an DM leiden. Man muss im Labor auch HbA1C und Serumglukose kontrollieren.

Mousarmsyndrom: Ursache? Das Mousarmsyndrom tritt auf, wenn der Nerv in Ihrem Arm durch eine lange Zeit in der gleichen Position, zum Beispiel beim Arbeiten am Computer, gereizt wird. Das kann Schmerzen oder Hypästhesie verursachen. Beim Mousarmsyndrom ist der Nervus radialis betroffen.

Was ist Valium? Valium ist der Markenname für das Medikament Diazepam.

Was ist Kropf, was Endemie, und wie kann ich diese Begriffe verbinden? Ein Kropf, auch als Struma bezeichnet. Ein **Kropf** ist eine Vergrößerung der Schilddrüse. Er entsteht häufig aufgrund eines Jodmangels. **Endemie** bezeichnet das regelmäßige oder konstante Auftreten einer Krankheit in einer bestimmten Region.

Was ist Gelbschein? Gelbschein könnte umgangssprachlich Gelbsucht meinen.

In welchem Zustand befinden weiße Mäuse sich? Mausarm? Mauserarm ist ein umgangssprachlicher Begriff für repetitive Strain Injurie (RSI) oder Mausarm-Syndrom.

Karpaltunnelsyndrom, und warum ist oft dieses Syndrom bei der Schwangeren? Das Karpaltunnelsyndrom ist eine spezielle Form des Überlastungssyndroms. Medianusnerv im Handgelenk (im Karpaltunnel) wird komprimiert.

Valium: Handelsname von Benzodiazepin. Benzodiazepine sind eine Klasse von Medikamenten. Die werden Angstzuständen, Schlafstörungen, Muskelverspannungen und Krampfanfällen eingesetzt.

Herr Lindner Ka Werte von 2.52 mmol/ L

Welchen genauen Knochen hat der Patient gebrochen? Wie war die Frakturbehandlung? Haben die Ärzte die Platten und Schrauben sofort entfernt?

Gab es Komplikationen? Wenn ja, welche und warum? Er hat eine Intoleranz gegen **Plexumanësthesie,** CAVE: NICHT Allergie gegen Narkose

Was ist DM? Was passiert bei einem DM-Typ 1? beim DM-Typ 2?

Was sind exokrin und Endokrin Insuffizienz?

Bei der endokrinen Funktion des Pankreas werden Insulin und Glukagon produziert. Eine endokrine Pankreasinsuffizienz tritt auf, wenn das Pankreas nicht genügend dieser Hormone produziert und Deswegen kann Diabetes mellitus entstehen.

Bei der exokrinen Funktion des Pankreas werden Verdauungsenzymen (Lipaze, Amilaze) produziert. Eine exokrine Pankreasinsuffizienz tritt auf, wenn das Pankreas nicht genügend dieser Enzyme produziert.

Warum hatte der Patient solche Angst, dass er in die Notaufnahme kam? Er hat gefragt, Leide ich an einen HI, wie mein Vater?

Was ist Rückschüle? Ist ein Kurs, bezeichnet die Informationen und Übungen, um Rückengesundheit zu verbessern

Welche apparativen Diagnostiken würden Sie vorschlagen? Röntgen, EKG, CT

Das RSI-Syndrom steht für "Repetitive Strain Injury" oder "Repetitive Stress Injury" Es handelt sich um eine Verletzung, die durch wiederholte Bewegungen und übermäßige Beanspruchung bestimmter Körperteile entsteht, insbesondere der Hände, Handgelenke, Arme, Schultern und des Nackens. Diese Art von Verletzung ist häufig bei Menschen, die repetitive Tätigkeiten ausführen, wie z. B. Arbeiten am Computer, Musizieren oder bestimmte industrielle Arbeiten.

RSI: Es handelt sich um eine Verletzung oder Schädigung von Muskeln, Nerven durch wiederholte Bewegungen und übermäßige Belastung, insbesondere im Arbeitsumfeld.

Die "Leitungsanästhesie" bezeichnet eine Form der Lokalanästhesie.

Die Eigenbluttherapie ist ein Behandlungsverfahren, bei dem Patienten eigenes Blut entnommen wird und nach verschiedenen Aufbereitungstechniken erneut injiziert wird.

Angestellte sind für die Verwaltung von Personenmeldungen in einem Einwohnermeldeamt zuständig. Meningitis: Hirnhautentzündung Nackensteifigkeit: Meningismus

Die Lumbalpunktion: ist schmerzhaft und invasiv. Sie wird durchgeführt, um die Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit zu untersuchen. Sie müssen nüchtern bleiben und eine bestimmte Position einnehmen. Nach dem Eingriff benötigen Sie Bettruhe. Der Eingriff dauert in der Regel etwa 15 bis 30 Minuten.

Bei HWS-Röntgen: Erhöhung der Lordose im Bereich der HWS.

MRT: ist der Abkürzung von Magnetresonanztomographie, ein bildgebendes diagnostisches Verfahren. Es ist schmerzlos und Strahlenfrei. Das MRT verwendet ein starkes Magnetfeld und Radiowellen. Sie liegen auf dem Rücken. Wir beurteilen der inneren Organe und Gewebe. Es dauert 20 bis 60 Minuten.

12. Hyperthyreose

İçindekilere dön

o **Haben Sie neben dem Herzrasen noch andere Beschwerden, z. B. Schwindel?** o **Welche Art von Schwindel ist es?** Eher wie Karussellfahren oder wie auf einem Boot? o **Wie lange dauert eine Schwindelattacke?** o **Haben Sie schon einmal das Bewusstsein verloren? War jemand dabei?** o **Haben Sie dabei auf die Zunge gebissen oder unwillkürlich Urin verloren?** o **Haben Sie Lähmungserscheinungen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle bemerkt?** o Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Seh- oder Hörstörungen haben? o Sind Sie lichtempfindlich? o **Haben Sie ein Kloßgefühl im Hals bemerkt?** o **Haben Sie eine Vergrößerung am Hals bemerkt?** o **Haben Sie Heiserkeit oder Schluckstörungen?**	o **Sind Sie überempfindlich gegenüber Wärme?** o **Fühlen Sie sich nervöser oder reizbarer als sonst?** o Können Sie sich gut konzentrieren? o **Schwitzen Sie mehr als sonst?** o Wie ist Ihr Appetit? o Haben Sie Gewichtsveränderungen festgestellt? o **Zittern Ihre Hände während der Attacken?** o Haben Sie Haarausfall bemerkt? o Wie ist Ihr Stuhlgang? Ist alles in Ordnung?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Schilddrüsenüberfunktion. Das bedeutet, dass Ihre Schilddrüse zu viele Hormone produziert. Diese Hormone machen den Körper schneller. Deshalb können Symptome wie Herzklopfen, Nervosität, Gewichtsverlust oder Schwitzen auftreten. Die Erkrankung ist gut behandelbar. Wir können Medikamente geben, die die Hormonproduktion reduzieren.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen Halsultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Maja Wüller. Sie **ist** 46 Jahre **alt, geboren** am 01.01.1977. Sie ist 1,67m **groß** und **wiegt** 77,3 kg.

Sie kam heute zu uns wegen heute Morgen aufgetretenem Herzrasen und Angst vor Umkippen.

Laut Aussage der Patientin sind die Beschwerden plötzlich und attackenartig **aufgetreten.**

Nach Angaben der Patientin dauert jede Episode etwa 15 Minuten.

Außerdem berichtet sie, dass sie insgesamt zwei Synkopen hatte: die erste vor zwei Wochen, die zweite vor zehn Tagen. (*Während der Synkopen habe sie eingenässt*). Krämpfe oder Zuckungen wurden verneint.

Begleitend klagt sie über Globusgefühl, Wärmeintoleranz, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Tinnitus, Parästhesien an den Händen, Tremor in den Händen während und unmittelbar nach den Attacken, eine Gewichtsabnahme von 5 kg in vier Wochen trotz Heißhunger, Hyperhidrose und dünnen Stuhl 1–2-mal täglich seit zwei Wochen.

Vegetativanamnestisch ergab sich Insomnie.
Des Weiteren ist die Periode regelmäßig. Letzte Periode war vor 14 Tagen.

An Vorerkrankungen leidet sie seitdem 18.LJ. **an** Endometriose.

An Operationen sind eine Tonsillektomie *mit 10 LJ.*, eine Appendektomie *mit 18 LJ.* sowie eine Extrauteringravidität *mit 25 LJ.* **bekannt.**

Der Patient nimmt Minulet regelmäßig sowie Baldrian bei Bedarf **ein**.

Sie hat eine Allegie gegen braunes Pflaster**, die sich durch** Erythem und Ödem **äußert.**

Bei der Noxenanamnese berichtete sie über einen Nikotinkonsum **von** 2 Packyears bis vor 25 Jahren sowie über den Konsum von 2 Gläsern Wein pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab Alkoholsucht, Arthritis urica und Sepsis **beim Vater,** an dem er im Alter von 89 Jahren verstorben ist**, sowie** Morbus Crohn **bei der Mutter**.
Sozialanamnestisch ist sie Schuhverkäuferin, wohnt mit ihrem Freund zusammen und hat keine Kinder**.**

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine **Hyperthyreose**.
Dafür sprechen Tachykardie, Angst vor Umkippen, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Wärmeintoleranz, Gewichtsabnahme trotz Heißhunger, Parästhesien und Tremor der Hände, dünner Stuhl und Hyperhidrose

Differenzialdiagnostisch kommen Herzrhythmusstörungen (PSVT, Vorhofflimmern) sowie eine Panikattacke **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.**

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine HRST auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, **Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte** , BZ, Schilddrüsenparameter (TSH, fT3, fT4, TRAK, Anti-TPO), D-Dimer **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich ein Schilddrüsen-Sonographie durchführen, ein Langzeit-EKG, CT-Schadel, ggf. eine Feinnadelpunktion, ggf. eine Szintigraphie sowie ggf. eine Carotis-Duplexsonographie ein Röntgen-Abdomen sowie ggf. ein CT-Angiographie **veranlassen.**

Ich werde ein endokrinologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin **stationär** aufnehmen.
Als Therapie würde ich ein Thyreostatikum (Carbimazol oder Propylthiouracil) sowie einen Betablocker (z. B. Propranolol) **verordnen.**

Ggf. können eine Radiojodtherapie oder eine operative Therapie erforderlich sein.

Globusgefühl = Kloßgefühl

13. LUMBALGIE

İçindekilere dön

• Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Fehlbewegungen, Hebetrauma oder Kälteexposition? Haben Sie sich an Rucken verletzt? • Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen oder Kraftverlust haben? • Haben Sie Kribbelgefühle oder Taubheitsgefühle bemerkt? • Haben Sie unwillkürlich Urin oder Stul verloren? • Tragen Sie häufig schwere Sachen? • Treiben Sie Sport?	• Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? z.B. ins Bein, bis zu Fuß (sehr wichtig) • Trotz Ihrer Pollenallergie: Können Sie als Floristin problemlos arbeiten, oder haben Sie dabei Beschwerden?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **eine Muskelverspannung aufgrund des Hebens eines schweren Kübels.** Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.

Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme Ihrer Lenden und auch eine MRT veranlassen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Astrid Fischelmann. Sie ist 55 Jahre alt, geboren am 11.04.1970. Sie ist 1,64 m groß und wiegt 64,3 kg.

Frau Fischelmann kam heute zu uns wegen seit gestern bestehender Schmerzen im unteren Lendenbereich.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich nach einer Hebung eines schweren Kübels aufgetreten.

Sie berichtet, dass die Schmerzen ins linke Bein bis zum Fuß **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen stechend, brennend, ziehend, persistierend und progredient.

Die Schmerzintensität liegt bei 7/10 auf der NRS.

Die Schmerzen verschlimmern sich beim Aufstehen, Sitzen und nach vorne Beugen, **während sie sich** beim Liegen, bei Beinhochlagerung und nach der Einnahme von Diclofenac 75 mg **bessern.**

Außerdem erwähte sie, dass sie seit einem Jahr ähnliche Beschwerden **hat, damals waren sie jedoch leichter.**
Die Fragen nach Parese, Parästhesie und Urin-Stuhlinkontinenz wurden verneint.

Begleitend klagt er über der Übelkeit nach Einnahme von Diclofenac .

Vegetativ-anamnestisch ergab sich Kaltschweißigkeit.

Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.

An Vorerkrankungen leidet sie seit Jahren an Migräne .

An Operationen sind Sectio caesarea vor 30 Jahren und Vakuumextraktion vor 28 Jahren **bekannt.**

Sie **nimmt** regelmäßig Ibuprofen 400 mg b. B., Dolortriptan b. B. und Calcium Sandoz b. B. **ein.**

Sie hat eine Pollenallergie, **die sich durch** Rhinokonjunktivitis **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie zwei Gläsern Wein am Wochenende.

Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie **beim Vater,** Diabetes mellitus Typ II **bei der Mutter** und Lungenkarzinom bei der Schwester, woran sie gestorben ist.

Sozialanamnestisch ist sie Floristin **von Beruf**, geschieden, wohnt allein und hat zwei Söhne

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf Lumbalgie. **Dafür sprechen** Lumbalgie mit Ausstrahlung ins linke Bein, das Auftreten nach einer Hebung eines schweren Kübels, ohne Parese, ohne Parästhesie, ohne Urin-Stuhlinkontinenz. **Differentialdiagnostisch kommen** Spinalkanalstenose, Lendenwirbelfraktur **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen und dabei insbesondere die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, die paravertebrale Druckschmerzhaftigkeit, Muskelverspannungen sowie mögliche

neurologische Defizite wie Sensibilitätsstörungen, Paresen und Reflexveränderungen **überprüfen. Zudem werde** ich das Lasègue-Zeichen **überprüfen.**

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte , Nieren- und Leberwerte, Vitamin-D3-Profil sowie einen Urinstatus **bestimmen lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Röntgenaufnahme des Lendenbereichs in zwei Ebenen und ggf. ein MRT **veranlassen.** Ich werde ein orthopädisches Konsil anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin ambulant **behandeln.**

Als initiale Therapie würde ich Analgetika (z.B.Metamizol) und Muskelrelaxantien (Tolperison, Methocarbamol, Tizanidin, Baclofen) und ggf. eine Einspritzung von Kortison **verordnen.**

Außerdem empfehle ich als kausal Therapie Physiotherapie (Krankengymnastik) und die Patientenschulung

Eine operative Therapie, wie z. B. eine Nukleoplastie, wird vorgeschlagen, wenn ein schwerer Bandscheibenvorfall vorliegt oder Red-Flag-Symptome auftreten, wie z. B. Reithosenanästhesie, Harn- und Stuhlinkontinenz, Paresen, Zustand nach Wirbelfraktur, bekannte Osteoporose oder Infektionen

Lasègue-Test:

- Der Test wird durchgeführt, um zu prüfen, ob eine Reizung des Ischiasnervs vorliegt.
- Der Patient liegt auf dem Rücken und das gestreckte Bein wird langsam angehoben. Wenn dabei Schmerzen auftreten, die vom unteren Rücken ins Bein ausstrahlen, gilt der Test als positiv.
- Ein positiver Lasègue-Test spricht häufig für eine **Nervenwurzelreizung**, zum Beispiel bei einem **Bandscheibenvorfall**.

MRT-Indikationen / Wichtige Zeichen

- **Neurologische Ausfälle:** Sensibilitätsstörungen, Paresen, Reflexabschwächung
- **Radikuläre Symptome:** Ischialgie, dermatombezogene Schmerzen, positiver Lasègue-Test
- **Red-Flag-Symptome:** Blasen- oder Mastdarmstörungen, Reithosenanästhesie, starke/progrediente Schmerzen, Fieber, Tumoranamnese, Gewichtsverlust
- **Therapie-resistenter Verlauf:** Schmerzen, die nach 4–6 Wochen konservativer Therapie nicht besser werden

14. Mesenterial Infarkt

İçindekilere dön

o **Gibst es etwas, das die Schmerzen verstarkt z.B. Bewegung oder lindert z.B. nach dem Stuhlgang** o **Ist Ihr Bauch dicker und härter geworden?** o **Wie sieht Ihr Stuhl aus? Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?** o **Wann war der letzte Stuhlgang?** o **Gehen Winde ab?**	o **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Herzrasen, Kaltschweiß, Schwindel, Müdigkeit oder eine schnellere Atmung haben?** o **Wann war die letzte INR-Kontrolle und wie hoch war der Wert?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **eine Durchblutungsstörung des Darms. Dabei bekommt ein Teil des Darms nicht genug Sauerstoff.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und einen Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Gisela Reuters. Sie **ist** 63 Jahre **alt, geboren** am 01.02.1962. Sie ist 1,65m **groß** und **wiegt** 71,3 kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit eineinhalb Stunden bestehender Bauchschmerzen im Bereich des Bauchnabels.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach dem Frühstück plötzlich **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen nirgendwohin ausstrahlen.

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen kolikartig.

Die Schmerzintensität liegt bei 8-9/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei……., **während sie sich** ……..**bessern.**

Außerdem erwähnt sie, dass sie seit vier Wochen ähnliche Beschwerden **hat**. Damals waren die Schmerzen dumpf, diffus und erträglich; seit eineinhalb Stunden sind sie jedoch unerträglich geworden.

Begleitend klagt sie über Hyperhidrose, Tachykardie und Übelkeit

Vegetativanamnestisch ergaben sich stressbedingte Durchfall, arbeitsbedingte Insomnie, eine Gewichtszunahme von 2 kg in drei Monaten
Des Weiteren ist sie seit 13 Jahnren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 15 Jahren **an** arterieller Hypertonie, seit fünf Jahren **an** Vorhofflimmern, **an** Raucherhusten (V. a. chronische Bronchitis im Rahmen des Nikotinkonsums), seit drei Tagen **an** Tinnitus sowie an einem Zustand nach Hepatitis A.

An Operationen ist eine Inguinalhernieoperation (vor 15 Jahren) **bekannt.**

Der Patient nimmt Beloc-Zok® 95 mg, ASS 100 mg und Marcumar **ein**.Die genaue Dosierung von Marcumar® ist der Patientin nicht bekannt.

Sie hat eine Penicillinallergie**, die sich durch** Pruritus, Durchfall, Übelkeit und Erythemen **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie einen Nikotinkonsum von 72 Packyears sowie über den Konsum von einem Glas Wein am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt **beim Vater,** an dem er im Alter von 89 Jahren verstorben ist, und einen Apoplex **bei der Mutter**, an dem sie im Alter von 65 Jahren verstorben ist.
Sozialanamnestisch ist sie Landschaftsbaubesitzerin, **verheiratet** und **wohnt** mit ihrer Familie zusammen. Sie **hat** einen Sohn.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein akutes Abdomen im Rahmen eines Mesenterialinfarkts. **Dafür sprechen** die kolikartigen Bauchschmerzen mit

postprandialem, plötzlichem Beginn, die hohe Schmerzintensität sowie die vegetativen Begleiterscheinungen und das bekannte Vorhofflimmern.

Differenzialdiagnostisch kommen eine akute Appendizitis, eine akute Pankreatitis und ein akutes Koronarsyndrom (ACS) **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.**

Auserdem sollte ein EKG geschrieben werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, **Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte** , **Cholestaseparameter, Lipase, Amylase, Herzmuskelenzyme, eine BGA (Laktat, Base Excess, pH-Wert), Quick-Wert, INR, PTT, D-Dimer, einen Urinstatus sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich ein Sono-Abdomen durchführen, ein Röntgen-Abdomen sowie ggf. ein CT-Angiographie **veranlassen.**

Ich werde ein chirurgisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin i**ntensivstationär** aufnehmen.
Als initiale Therapie würde ich Nahrungskarenz, das Legen einer Magensonde, Flüssigkeitszufuhr d Elektrolytsubstitution sowie Analgetikum (z. B. Metamizol), Antiemetikum und Antibiotikum **(z. B.** Ciprofloxacin (wegen Penicilinallergie) **und Metronidazol**) **verordnen.**
Als kausale Therapie kommt eine explorative Laparotomie bzw. eine operative Versorgung in Betracht.

15. OSAS

İçindekilere dön

• **Gibt es eine Ursache dafür, dass Sie sich müde fühlen? Vielleicht Schmerzen oder Schlafstörungen?** • **Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?** • Haben Sie Konzentrationsstörung oder ständige Müdigkeit? • Haben Sie Schläfrigkeit tagsüber? • Wann genau treten Kopfschmerzen auf? • **Hat Ihr Mann in letzter Zeit bemerkt, dass Sie laut schnarchen oder Atemaussetzer im Schlaf haben?** • Wie viele Kissen benutzen Sie beim Schlafen? • **Schlafen Sie auf dem Rücken oder seitlich?** • **Atmen Sie beim Schlafen durch die Nase oder den Mund?** • Darf ich fragen, ob Sie Problem beim Sex haben?	**einnicken** → kurz einschlafen **würgen** → sich verschlucken / Würgereiz haben **keuchen** → schwer atmen, nach Luft ringen **„Frosch im Hals“** → Globusgefühl

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **eine schlafbezogene Atmungsstörung. Das kann zu Atempausen führen, den Schlaf stören und den Körper belasten. Ursachen dafür können zum Beispiel Übergewicht, Alkoholkonsum, bestimmte Schlafpositionen, Veränderungen im Rachenraum oder eine vermehrte Muskelerschlaffung im Schlaf sein.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach sollten wir einen Termin vereinbaren beim HNO-Arzt .**Er würde Sie** gerne untersuchen und für eine Nacht **in ein Schlaflabor überweisen. Dort wird bei Ihnen Polysomnographie durchgeführt. Das ist wichtig, damit wir Ihren Schlaf analysieren. Wissen Sie was das ist?**

Polysomnographie

- Eine **Polysomnographie** ist eine Untersuchung, die Ihnen Schlaf aufzeichnet.

- Durch diese Untersuchung können wir Ihre Hirnaktivität, Herzrhythmus, Schnarchen, Atempausen, Atemfluss, Augenbewegungen, Muskelaktivität messen und ihren Schlaf beurteilen.
- Diese Untersuchung wird gemacht, um Schlafstörungen wie Schlafapnoe oder Schnarchen abzuklären.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Michaela Schiller. Sie **ist** 55 Jahre **alt, geboren** am 14.10.1968. Sie ist 1,63 m **groß** und **wiegt 85,3** kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit seit 3-4 Wochen bestehender Müdigkeit und progredienter Konzentrationstörung.

Begleitend klagt sie über Insomnie, nächtliche Apnoe, Rhonchopathie und Nykturie. **Zudem erwähnt sie**, **dass sie** morgendliche leichte Kopfschmerzen im Frontalbereich, trockenen Mund und tagsüber Schläfrigkeit **hat.**

Der Ehemann habe bemerkt, dass sie lautes Schnarchen und Atempausen beim Schlaf hat.

Vegetativanamnestisch ergaben sich nächtliche Hyperhidrose, eine Verstopfung und eine Gewichtszunahme von 20 kg in 3 Jahren.

Des Weiteren ist sie seit 6 Jahren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie seit 5 Jahren **an** arterieller Hypertonie, seit 3 Jahren **an** Hypercholesterinämie

An Operationen ist eine Cholezystektomie **bekannt.**

Die Patientin nimmt regelmäßig Valsartan 80 mg einmal morgens und Liptruzet 10 mg/20 mg einmal abends **ein**.

Sie hat eine Allergie gegen braunes Pflaster, **die sich durch** Pruritus und Erythem **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie 2 Gläser Wein am Wochenende. Nikotin-und Drogenkonsum wurden verneint.

Die Familienanamnese ergab einen Apoplex **beim Vater,** Depressionen **bei der Mutter**.

Sozialanamnestisch ist sie verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat 2 Tochter, 2 Enkelkinder.
Sie ist Krankenschwester von Beruf, arbeitet jedoch zurzeit nicht.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein obstruktives Schlafapnoesyndrom**. Dafür sprechen** Konzentrationsstörung, tagsüber Müdigkeit, morgendliche Kopfschmerzen, nächtliche Apnoe und Rchonhopathie

Differentialdiagnostisch kommen eine Anämie und eine Hypothyreose **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.**

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache abzuklären.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte , Ferritin, Transferrin, VitB12, Folsäure, Schilddrüsenhormone (TSH, fT3, fT4) , Lipidprofil, BGA, HbA1c und BZ **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Polysomnographie **veranlassen.**

Ich werde ein HNO- und Pneumologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin **ambulant behandeln und einen Termin beim Schlaflabor vereinbaren.**

- **Als initiale Therapie empfehle ich** Lebensstilveränderung, wie Gewichtsreduktion, eine gesunde Diät, und Sport.
- **Außerdem wird es empfohlen** auf der Seite zu schlafen und nicht auf dem Rücken. Zudem Alkoholkarenz.
- **Wenn das nicht reicht oder wenn das Syndrom zu stark ausgeprägt ist, schlage ich** eine nächtliche Beatmung durch ein nasales cPAP-Gerät **vor.**
- **Ggf. könnte auch eine Operation wie Uvulopalatopharyngoplastik, Septumplasik oder Conchotomie in Betracht gezogen werden.**

16. PNEUMONIE

İçindekilere dön

• **Seit wann haben Sie Husten?** • Ist der Husten dauerhaft da, oder kommt er in Attacken? • **Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?** • **Welche Farbe und Konsistenz hat der Auswurf?** • **Gibt es Blut im Auswurf?** • Haben Sie dabei Luftnot? • Tritt die Luftnot bei Belastung oder auch in Ruhe auf? • Wird es schlimmer, wenn Sie sich hinlegen?	• Haben Sie Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen oder Muskelschmerzen? Fühlen Sie sich müde oder abgeschlagen? Haben Sie pfeifende Atemgeräusche bemerkt? Haben Sie Geschmacks- oder Geruchsverlust bemerkt? • Gab es in letzter Zeit jemanden in Ihrer Umgebung, der ähnliche Symptome hatte oder krank war? • Wie sieht Ihre Arbeit aus? Sind Sie Holzstaub ausgesetzt?

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **eine Lungenentzündung.** Das bedeutet, dass sich das Lungengewebe entzündet hat . Das kann zu Husten, Fieber, Atemnot oder Schmerzen beim Atmen führen. Ursache können z. B eine Infektion mit Bakterien, seltener durch Viren oder geschwächtes Immunsystem. Das ist nicht so schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend Blut für das Labor abnehmen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme der Lunge machen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. **Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass** Herr Meier **einen** Kaliumspiegel **von** 2,6 mmol/l **hat**. **Dieser Wert ist** stark erniedrigt und **entspricht** Hypokaliämie. **Nun möchte ich gerne über den Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen?**

Es geht um Herrn Tim Jelscht. **Er ist 39 Jahre alt, geboren am** 08.04.1986**. Er ist 1,73 m groß und wiegt 80 kg**.

Er kam heute zu uns wegen seit 6 Tagen bestehendem Husten.

Laut Angaben des Patienten ist der Husten produktiv mit. gelblich-grünlichem Sputum.

Er berichtet, dass er seit 3 Tagen Brustschmerzen **hat.**

Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten, persistierend, progredient sowie ziehend und stechend. **Er erwähnt, dass die Schmerzen** nicht **ausstrahlen und die Schmerzintensität bei** 6/10 **auf der NRS liegt.**

Die Beschwerden verschlimmern sich im Liegen**, während sie sich im** Sitzen und Stehen **bessern.**

Begleitend klagt er seit 3 Tagen über eine bewegungsunabhängige Dyspnoe sowie über Fieber bis 38,7 °C.

Außerdem berichtet er, dass seine Tochter vor einer Woche ähnliche Beschwerden hatte; sie ist inzwischen wieder gesund.
Ein COVID-19-Test wurde durchgeführt und war negativ.

Vegetativ-anamnestisch ergaben sich Insomnie, ein gewollter Gewichtsverlust von 4 kg in 3 Monaten, Müdigkeit und Inappetenz.

An Vorerkrankungen leidet er seit 3 Jahren **an** aHT .

An Operationen sind (mit 11 Monaten)eine Orchidopexie **und (**mit 15 Jahren) eine Appendektomie **bekannt.**

Der Patient nimmt regelmäßig Ramipril 5 mg einmal morgens **ein.**

Er hat eine Novalgin**allergie**, **die sich durch** Emgegefühl **äußert.**

Bei der Noxenanamnese erwähnte er lediglich ein Glas Rotwein pro Woche **.**

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater (verstorben mit 60 Jahren), Morbus Parkinson **bei der Mutter** sowie ein Bronchialkarzinom beim Großvater (verstorben mit 65 Jahren).

Sozialanamnestisch ist er Tischlermeister**, verheiratet und lebt in einer homosexuellen Beziehung; er hat** eine adoptierte Tochter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Pneumonie. **Dafür sprechen Dyspnoe, produktiver Husten, ziehend-stechende Brustschmerzen, Fieber, Müdigkeit sowie eine ähnliche Erkrankung der Tochter vor einer Woche**

Differentialdiagnostisch kommen Bronchialkarzinom, Bronchitis in **Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der Auskultation suche ich nach feuchten Rasselgeräuschen. Zudem werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache abzuklären**.**

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, BGA, Elektrolyte sowie Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen. Zusätzlich würde ich eine Sputumkultur veranlassen.

Darüber hinaus werde ich eine Röntgen-Thorax in 2 Ebenen veranlassen, ggf. ein CT-Thorax.

Ich werde bei Bedarf ein pulmonologieches Konsil anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten zunächst ambulant behandeln; je nach Befunden ist jedoch eine stationäre Aufnahme erforderlich.

Ich würde eine Infusionstherapie (Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution) **sowie eine symptomatische Behandlung** mit Analgetikum, Antipyretikum (z. B. Paracetamol), einem Mukolytikum (z. B. Acetylcystein) und Sauerstoffgabe über Nasensonde bei $SaO_2 < 92\ \%$ **verordnen.**

Die Bettruhe wird empfohlen.

Ein kalkuliertes Antibiotikum wie Amoxicillin/Clavulansäure **wird verodnet. Je nach Ergebnisse der** Sputumkultur kann das Antibiotikum **geändert werden.**

17. Pankreatitis

İçindekilere dön

•	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine **Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das kann zu starke Schmerzen im Oberbauch, die manchmal in den Rücken ausstrahlen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber oder ein aufgeblähter Bauch. Ursache können z.B Gallensteine oder übermäßigen Alkoholkonsum. erhöhte Blutfettwerte oder bestimmte Medikamente sein.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen und einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen.Danach werde ich einen Bauchultraschall durchführen.Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über meinenr Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Herrn Dieter Kazmarek. **Er ist** 59 **Jahre alt, geboren am** 31.12.1962**.Er ist 1,83 m groß und wiegt 74,3 kg**.

Er **kam heute zu uns wegen seit zwei bis drei Wochen bestehender Oberbauchschmerzen.**

Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen **plötzlich postprandial (nach dem Verzehr von Makrelen-Röllchen) aufgetreten.**

Er **berichtet, dass die Schmerzen** in den Rücken **ausstrahlen.**

Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen kolikartig und ziehend.

Schmerzintensität liegt bei 5-6/10 **auf der NRS**.

Außerdem erwähnt er , dass er seit drei Monaten ähnliche Beschwerden **hat, die Schmerzen jedoch im Verlauf schlimmer geworden sind.**

Begleitend klagt er (seit drei Wochen**) über** Übelkeit und (seit zwei Wochen) **über** Durchfall, vier bis fünfmal täglich, dünn, hellbraun und glänzend.

Außerdem hat er dunklen Urin und Nachtschweiß.

Vegetativanamnestisch ergaben sich Müdigkeit, Inappetenz, eine Gewichtsabnahme von 5–10 kg inerhalb von vier bis fünf Wochen und Dyssomnie.
Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig

Die Allergie-, Medikamenten- und Vorerkrankungsanamnese waren unauffällig, bis auf einen Clavus.

An Operationen ist vor 29 Jahren wegen eines Autounfalls eine Osteosynthese einer rechten Unterschenkelfraktur bekannt. Es gab Komplikationen, und er musste Bluttransfusionen erhalten.

Bei der Noxenanamnese erwähnte 40 py Nikotinkonsum, täglich drei bis vier Flaschen Bier seit 30 Jahren sowie mindestens zwei Schnäpse täglich und Cannabiskonsum bis vor einem Jahr.
Die Familienanamnese ergab ein Kolorektalkarzinom **beim Vater** und seine Mutter ist an Hämatemesis (im Alter von 66 Jahren) verstorben.

Sozialanamnestisch ist er seit fünf Jahren arbeitslos.Früher hat er als Schlosser gearbeitet. Er ist geschieden und hat eine Tochter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf **einen akuten Schub einer chronischen Pankreatitis**. **Dafür sprechen** die ziehenden, kolikartigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken, dunkler Urin, helle und glänzende Diarrhoe, Gewichtsabnahme, Inappetenz und Nausea

Differentialdiagnostisch kommen Pankreaskarzinom, eine Choledocholithiasis, ein Ulcus ventriculi und ein ACS **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen .

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um eine Herzerkrankung auszuschließen.
Bei der körperlichen Untersuchung werde ich auf Grey-Turner-, Cullen- und Fox-Zeichen sowie auf Ikterus **achten.**

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Lipase, Amylase, BZ, HbA1c, Elektrolyte, Herzenzyme, Cholestaseparameter , Nierenwerte, Leberwerte, Urinstatus, Lipidprofil sowie eine Stuhldiagnostik (Elastase-1) **bestimmen lassen.**
Des Weiteren werde ich Sono-abdomen **durchführen**, sowie ein CT-Abdomen mit Kontrastmittel und ggf. eine MRCP und ERCP bei biliärer Genese **veranlassen**

Zudem werde ich ein gastroenterologisches sowie ein chirurgisches Konsil **anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten **intensivstationär aufnehmen**.
Als initiale Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, Nahrungskarenz,Nikotin-und Alkoholkarenz

Als symptomatische Therapie werde ich Analgetikum (z. B. NSAR, Tramadol, ggf. Pethidin), Antiemetikum und einen PPI als Ulkusprophylaxen verordnen.

Darüber hinaus würde ich bei einer nekrotisierenden Pankreatitis eine antibiotische Therapie in Erwägung ziehen sowie gegebenenfalls eine Enzymersatztherapie und Vitaminpräparate **berücksichtigen.**

18. RDS

İçindekilere dön

Herzrasen?	
• Seit wann haben Sie Herzrasen? • Ist der Herzrasen plötzlich oder langsam aufgetreten? • Gibt es einen bestimten Auslöser für den Herzrasen? • Ist er dauerhaft da, geht er wieder weg? • Wie lange dauert eine Attacke? • **Haben Sie dabei Burstschmerzen, Lufnot oder Engegefühl?** • Ist es das erstemal oder hatten Sie schon früher ahnliche Symptome?	• **Gibt es einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung?** • Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen? • Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Ausstoßen? • **Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine **Funktionstörung des Darms. Das bedeutet**, dass Ihr Darm empfindlicher auf bestimmte Reize reagiert, ohne dass eine organische Ursache vorliegt. **Dies kann zu** Bauchschmerzen oder -krämpfen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung oder einem Wechsel zwischen beiden führen. **Ursachen können** zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel (fettreich, sehr ballaststoffreich oder blähend), Stress, hormonelle Schwankungen oder eine veränderte Darmflora nach Infekten sein.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen und einen Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über meinen Patienten berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Hernn Tobias Beckers. Er ist 39 Jahre **alt, geboren am** 01.02.1987. **Er ist** 1,71 m **groß und wiegt** 64,4 kg.

Herr Beckers **kam heute zu uns wegen seit** drei Tagen bestehender Bauchschmerzen im Oberbauch sowie Herzrasen seit heute Morgen.

Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen postprandial (nach dem Verzehr von Tofu mit Reis und Gemüse) **aufgetreten.**

Er berichtet, dass die Schmerzen nirgendwohin **ausstrahlen.**

Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen kolikartig und drückend.

Die Schmerzintensität liegt bei 3/10 **auf NRS.**

Die Schmerzen verbessern sich nach dem Erbrechen.

Außerdem erwähnt er, dass er seit fünf Jahren ähnliche Beschwerden hat, die Schmerzen jedoch im Laufe der Zeit schlimmer geworden sind.Deswegen war er vor drei Monaten bei seinem Hausarzt; ihm wurde eine ÖGD durchgeführt, ohne pathologischen Befund.

Begleitend klagt er seit drei Tagen **über** Übelkeit und seit heute Morgen **über** zweimaliges Erbrechen mit unverdautem Essen sowie seit gestern über Durchlall, zwei- bis dreimal täglich, cremig, breiig, flüssig und dunkelbraun.

Vegetativanamnestisch ergaben sich Inappetenz und schmerzbedingte Dyssomnie.

An Vorerkrankungen leidet er **seit** 2 Jahren **an** arterieller Hypertonie .

An Operationen ist eine Tonsillektomie (im 11. Lebensjahr) **bekannt.**

Der Patient **nimmt** Nebivolol 2,5 mg und Amlodipin 2,5 mg **ein**.

Er **hat eine Erdnüsseallergie, die sich durch** brennendes Gefühl, Schweißausbrüchen, Pruritus, Parästhesien und Wärmegefühl im Mund **äußert,** sowie eine Unverträglichkeit gegen Narkosemittel durch Erbrechen

Bei der Noxenanamnese erwähnte er lediglich zwei bis drei Gläser Alkohol (Schnaps, Bier, Weißwein, Rotwein, Rosé) abends, am Wochenende eher mehr.

Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie, Glaukom, Vorhofflimmern und Myokardinfarkt **beim Vater** sowie Diabetes mellitus Typ II und Clavus **bei der Mutter.**
Eine Schwester leidet an psychosomatischen Magen-Darm-Beschwerden, die andere an arterieller Hypertonie.

Sozialanamnestisch ist er Kommunikationsdesigner von Beruf, verheiratet und hat eine Tochter.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein Reizdarmsyndrom. **Dafür sprechen** die Bauchschmerzen, durchfall ohne Blut, der fehlende pathologische Befund in der ÖGD, Stress und Alkoholkonsum.

Differentialdiagnostisch kommen GERD, chronische Gastritis, akute Pankreatitis und Herzrhythmusstörungen **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen.

Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, BZ, HbA1c, Elektrolyte, Herzenzyme und Stuhlprobe kontrollieren lassen.

Darüber hinaus werde ich eine Abdomen**sonographie durchführen.**

Danach werde ich den Hausarzt nach dem Ergebnis der ÖGD fragen

Ich werde ein psychiatriesches -und ein gastroenterologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten **ambulant behandeln. Ich würde symptomatisch** Analgetikum, Antiemetikum **sowie ggf.** PPI und Antazida **verordnen.. Eine Alkoholkarenz und eine Ernährungsumstellung werden empfohlen**

19. SLE

İçindekilere dön

✓ **Seit wann haben Sie Müdigkeit?** ✓ **Gibt es eine Ursache dafür, dass Sie sich müde fühlen? Vielleicht Schmerzen oder Schlafstörungen?** ✓ ✓ **Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?** ✓ ✓ **Sind die Schmerzen symmetrisch?** ***Haben Sie Schwellungen, Rötungen oder Überwärmung irgendwo am Ihren Körper bemerkt? Beispielsweise an den Händen, Beinen, Gelenken…** ***Gibt es eine Morgensteifigkeit? Wenn ja, wie lange dauert sie?** ***Hatten Sie häufige Infekte, blaue Flecken oder Nasenbluten?**	✓ **Haben Sie Hautveränderungen im Gesicht oder an anderen Körperstellen bemerkt?** ✓ **Ist die Hautrötung trocken oder nässend?** ✓ **Treten die Hautveränderungen nach Sonnenexposition auf?** ✓ **Wie äußert sich die Sonnenempfindlichkeit?** ✓ **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie wunde Stellen im Mund oder an der Nase haben?** ✓ **Haben Sie Haarausfall bemerkt?** ✓ **Haben Sie Veränderungen beim Wasserlassen festgestellt?** ✓ **Ist der Urin schaumig?** ***Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ein geschwollenes, gerötetes und überwärmtes Bein haben?** ***Hatten Sie schon einmal eine Fehlgeburt?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Lupus, eine Erkrankung, bei der das Abwehrsystem den eigenen Körper angreift. Dabei können verschiedene Organe wie Haut, Gelenke, Nieren oder Nerven betroffen sein. Das kann zu Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Müdigkeit, Fieber, Haarausfall oder Nierenprobleme.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. **Zunächst** werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich **ein EKG schreiben, Röntgen der Gelenke veranlassen und einen Bauchultraschall** durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Marina Müller. Sie **ist** 45 Jahre **alt, geboren** am 08.10.1979. Sie ist 1,71m **groß** und **wiegt** 75,3 kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit zwei Wochen bestehender Müdigkeit und Fieber (38,4 °C). Das Fieber wurde axillär gemessen.

Laut Aussage der Patientin leidet sie unter beidseitigen Arthralgien an den Handgelenken und Kniegelenken seit zwei Wochen**.**

(Sie berichtet, dass die Schmerzen *nirgendwohin* ***ausstrahlen.)***

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen brennend, ziehend.

Die Schmerzintensität liegt bei 5/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Belastung, während sie sich in Ruhe und nach der Einnahme von Voltaren 75 mg **bessern.**

Außerdem erwähnt sie, dass sie seit fünf Monaten schubweise Arthralgien **hat.**

Zudem erwähnt sie, dass sie seit zwei Monaten ein Schmetterlingserythem mit Pusteln hat.

Begleitend klagt sie über Nachtschweiß, Mundulzera und Dysurie.

Vegetativanamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Dyssomnie, ein Gewichtsverlust von 4 kg in 2 Wochen, Fieber, Todesangst und Inappetenz.
Des Weiteren ist sie seit 6 Jahren in Menopause.

An Vorerkrankungen hat sie vor drei Monaten eine Tonsillitis **erlitten**

An Operationen ist eine Osteosynthese (wegen einer Antebrachiumfraktur links vor 10 Jahren) **bekannt.**

Die Patientin nimmt bei Bedarf Voltaren 75 mg, Pantoprazol 20 mg und regelmäßig Minulet **ein**.

Die Allergieanamnese war unauffällig. In der Kindheit hatte sie eine Pollenallergie, die damals mit einer Eigenbluttherapie behandelt wurde.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie 2 Gläser Wein am Wochenende. Nikotin-und Drogenkonsum wurden verneint.

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom **beim Vater** (daran verstorben), eine rheumatoide Arthritis **bei der Mutter** und Psoriasis **bei der Schwester.**
Sozialanamnestisch ist sie Sozialarbeiterin/Pädagogin in einer Grundschule **von Beruf**, verheiratet, **wohnt** mit ihrer Familie zusammen und **hat** zwei Kinder.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf einen systemischen Lupus erythematodes. **Dafür sprechen** beidseitige Hand- und Kniegelenkschmerzen mit

Entzündung (Tumor, Calor, Rubor), Müdigkeit, Schmetterlingserythem, Gewichtsabnahme, Dysurie sowie ein schubweiser Verlauf seit fünf Monaten. **Auch** die Familienanamnese mit rheumatoider Arthritis bei der Mutter und Psoriasis bei der Schwester spricht dafür.

Differentialdiagnostisch kommen rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, w erde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.** Bei der Inspektion werde ich darauf achten, ob ein typisches Schmetterlingserythem im Gesicht, Schwellungen, Rötungen, Fehlstellungen an den Gelenken, Haarausfall und Schleimhautgeschwüre vorliegen. Bei der Palpation achte ich auf Druckschmerzen und Überwärmung der Gelenke sowie auf vergrößerte Lymphknoten und Druckschmerzhaftigkeit im Abdomen; bei der Auskultation auf Reibegeräusche an Herz und Lunge und bei der Perkussion auf einen gedämpften Klopfschall bei Pleuraerguss.

Auserdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Komplementfaktoren, den Coombs-Test (hämolytische Anämie), ANA-Titer (antinukleäre Antikörper > 1:80, spezifisch für SLE), Anti-dsDNA, Anti-Smith-Antikörper (spezifisch für SLE), Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte sowie einen Urinstatus (Proteinurie und Erythrozyturie) **bestimmen lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Röntgenaufnahme der Gelenke und einen Ultraschall der Nieren **durchführen.**

Ich werde ein rheumatologisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin **stationär aufnehmen.**

Die weitere Therapie hängt davon ab, wie die Krankheit verläuft.

- Bei leichtem Verlauf ohne Beteiligung lebenswichtiger Organe werden der Patientin NSAR, Hydroxychloroquin und Glukokortikoide bei entzündlichen Schüben verordnet.
- Bei schwerem Verlauf mit Beteiligung lebenswichtiger Organe werden der Patientin Glukokortikoide und ggf. zusätzlich Azathioprin, alternativ Methotrexat, weitere Immunsuppressiva (z. B. Cyclophosphamid, Ciclosporin, Mycophenolatmofetil) sowie Biologicals wie Belimumab verordnet.

Sonnenexposition zu vermeiden und die Anwendung von Lichtschutzsalbe werden empfohlen.

20. UAW von Chemotherapie

İçindekilere dön

• **Das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Darf ich fragen, ob es eine bestimmte Ursache gibt, dass Sie sich müde fühlen ? Vielleicht Schmerzen oder Schlafstörungen?** • **Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen? Vielleich haben Sie sich am Leistenbereich verletzt?** • **Aus welchem Grund wurde bei Ihnen eine Biospsie entgenommen?** • **Wo befindet sich der Schwarze Hautkrebs?** • Haben Sie dafür eine Therapie bekommen? • Haben sie **die Chemotherapieschema** dabei? • Wie heißt Ihr Hausarzt oder Onkologe? • Wann hat die Therapie begonnen? • Wie heißt Ihr Hausarzt oder Onkologien?	• **Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?** **Nasenblutung:** Wie oft ? **Atemnot:** seit wann? Besteht die Luftnot bei Bleastung oder auch in Ruhe? Haben Sie auch Brustschmerzen oder Engegefühl? • **Haben Sie Schwellungen, Rötungen oder Überwärmung an dieser Stelle bemerkt?** • **Haben Sie Wundsekret bemerkt?** • • **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ein geschwollenes, gerötetes und überwärmtes Bein haben?**

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Nebenwirkungen der Chemotherapie .** Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.

Ich werde mich zunächst mit Ihrem Onkologen in Verbindung setzen, um mehr zu erfahren. Dann werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich **ein EKG schreiben und einen Ultraschall Ihrer Leiste** durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Natriumwert von 168 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erhöht und entspricht Hypernatriämie. Nun möchte ich gerne über meine Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Birkett Meisen. Sie **ist** 56 Jahre **alt, geboren** am 15.05.1965. Sie ist 1,75m **groß** und **wiegt** 71,3 kg.

Sie kam heute zu uns wegen seit 2 Wochen bestehender Müdigkeit und Schmerzen im linken Inguinal Bereich.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach der Lymphadenektomie plötzlich **aufgetreten.**

Sie berichtet, dass die Schmerzen in den Rücken und ins linke Bein **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen ziehend und krampfartig.

Die Schmerzintensität liegt bei 6/10, nach Einnahme von Ibuprofen bei 3/10 **auf der NRS.**

Die Schmerzen verschlimmern sich beim Liegen auf der linken Seite und bei Bewegung **, während sie sich** nach Einnahme von Ibuprofen **bessern.**

Außerdem erwähnt sie , dass bei ihr vor 2 Monaten ein malignes Melanom diagnostiziert **wurde** und vor 2 Wochen **eine Chemotherapie eingeleitet wurde**.

Zudem erwähnt sie, dass die Wunde entzündet ist und juckt.

Begleitend klagt sie seit 4 Wochen über belastungsabhnängige Dyspnoe sowie über Übelkeit, seit 2 Wochen über Epistaxis-Episoden, die jeweils etwa 15 Minuten dauern.

Vegetativanamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Dyssomnie, ein Gewichtsverlust von 4 kg in 2 Wochen, Todesangst und Inappetenz.
Des Weiteren ist sie seit 6 Jahren in Menopause.

An Vorerkrankungen leidet sie an malignem Melanom (seit 2 monaten)

An Operationen sind eine Osteosynthese (wegen einer Antebrachiumfraktur links vor 10 Jahren) und **einen** eine Lymphknotenentfernung im linken Inguinalbereich (vor 2 Wochen) **bekannt.**

Die Patientin nimmt Ibuprofen 400 mg (viermal täglich) und Haldol, 5 Tropfen (viermal täglich) **ein**.

Die Allergieanamnese war unauffällig.

Bei der Noxenanamnese berichtete sie über den Konsum von ein bis 2 Gläsern Wein am Wochenende. Nikotin-und Drogenkonsum wurden verneint.

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom **beim Vater,** an dem er im Alter von 75 Jahren verstorben ist, und einen Apoplex **bei der Mutter** sowie Darmpolypen und RDS **bei der Schwester.**

Sozialanamnestisch ist sie Fachangestellte im Einwohnermeldeamt, derzeit arbeitsunfähig (AU), verheiratet und lebt mit ihrer Familie. Ihre Tochter ist schwanger, was ihr zusätzliche Sorgen bereitet.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Pansitopenie im Rahmen der Chemotherapie. Dafür sprechen Müdigkeit, Epistaxis, Dysphagie, Inappetenz, Gewichtsverlust von 4 kg in 2 Wochen, Übelkeit

Differentialdiagnostisch kommen eine Wundheilungsstörung, eine TVT, Lungenmetastasen **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich naturlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, **Blut für das Labor abnehmen.**

Außerdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen.

Im Labor würde ich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte , Gerinnungsparameter (u. a. D-Dimer), Herzmuskelenzyme, BZ, ggf Wunde Kultur **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich ein Inguinalsonographie durchführen, ein Röntgen-Abdomen sowie ggf. ein CT-Angiographie **veranlassen.**

Ich werde ein onkologisches sowie ein psychiatrisches **Konsil anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin **stationär aufnehmen und umkehrisolieren.**

Ich würde eine Infusionstherapie (Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution, Nahrungstoffzufuhr) sowie eine symptomatische Behandlung mit Wundversorgung, Analgetikum und Antiemetikum **verordnen.** Ggf. wird ein Antibiotikum **verordnet.**

Chemotherapie kann Knochen Mark Inhibition-Panzytopenie zu führen.

TVT: Venöse Durchblutungsstörung. Drückende Schmerzen, Farbveranderungen, Ödeme im Bein, dauerhaft Schmerzen, Reise, grösser Operation,

pAVK: arteriell KH wegen Atherosklerose. Es tritt eine arterielle Verengung auf. Deswegen verursacht arterielle Durchblutungsstörung, schmerzen bei Bewegung, kaltes Gefühl, Haarausfall, Blase Haut.

D-Dimer: Fibrin spalt Produkt

Farbkodiertesonographie: Es gibt durch Blutung Störung, Thrombose in den Venen

TVT-Therapie: Heparin iv, ASS iv, Bein Hoch Lagerung, Bewegung, Gewichtverlust, Kompressionsstrümpfe (Varis çorabı), Antikoagulantia

herr Keller kaliumwert von 2.53 mmol/l Frage nach die komplikationen von hypokalömie. Wenn der pt leidet unter Kammerflimmern? Schlägt das Herz in dieser Situation? Was machen Sie?

Herr Eckert, Hb-Wert von 5,33 g/dL.

Laborzettel mit Leukopenie (3000/uL), Anämie (Hb 11,3 g/dL), Thrombozytopenie (70000/uL), Hämatokrit um 35%. Fragen der Prüfer:

Anämie Typen und deren Ursachen. „Was noch wichtig? Zwischen akut und chronisch zu differenzieren.

Welches Chemotherapikum ist für das Herzen giftig? Doxirubicin. Antrazyklin, bestimmte zielgerichtete Therapien wie Trastuzumab (Herceptin) und Tyrosinkinase-Inhibitoren wie Imatinib.

Metastase Ziele malignes Melanom? Leber, Knochen, Gehirn, Lunge

Metastase Ziele Lungenkarzinom? Leber, Knochen, Gehirn, Lymphknoten

Welcher Durchmesser bei melanozytären Nävi gefährlich? Mehr als 6mm Durchmesser, Veränderungen in Farbe, Form oder Größe des Näves im Laufe der Zeit

Was ist Sentinel-Lymphknoten? Wie entdeckt man er? Der Sentinel-Lymphknoten ist der erste Lymphknoten, in den der Tumor metastasiert.

Kann es sein, dass die Pat. eine Infektion im Bereich der LAD hat? Ja, wegen Immunsupression.

Morphin. Was ist? Wann benutzen wir am liebsten, in welcher Lebensphase? Am Ende, in der Palliativmedizin.

BTM – Betäubungsmittel **kg –** Kilogramm **KG -** Körpergröße, Körpergewicht **HWI -** Harnwegsinfekt, Hinterwandinfarkt

Wo genau war das Muttermal (neavus)?

Was hat die pt. Vor 3 Jahren?

Was ist Ihr Verdacht?

Warum hat die pt. Dyspnoe? Anämie

Wer kümmert sich um ihre Mutter?

Fachbegriffe: Meningitis, Hirnhautentzündung, akut, plötzlich auftretend, chronisch, lange andauernd

Was ist Glykosurie? Es ist Glukose im Urin und entsteht, wenn der Blutzuckerhoch ist.

Was ist Prophylaxe? Prophylaxe bezeichnet Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten oder Gesundheitsproblemen.

was ist Verbeugung? Eine Verbeugung ist eine höfliche Geste, bei der man den Oberkörper vorne beugt.

Was ist ÖGD? Was ist LWK und wie viele sind?

Labor: Erythrozytenzahl erniedrigt, Leukozytenzahl erniedrigt, Thrombozytenanzahl erniedrigt

Warum denkst du Panzytopenie?

Palliative Therapie lindert Symptome und verbessert die Lebensqualität bei schweren Krankheiten.

Curative Therapie ist darauf ausgerichtet, eine Krankheit zu heilen oder sie in Remission zu bringen.

Complette Remission bedeutet, dass bei einem Patienten keine Anzeichen oder Symptome der Krankheit mehr nachweisbar sind und dass alle diagnostischen Tests normal sind.

Partielle Remission bedeutet, dass die Krankheit teilweise zurückgegangen ist,

- **A = Asymmetrie der Veränderung**
- **B = Begrenzung ist unregelmäßig**
- **C = Colorit (uneinheitliche Pigmentierung = Polychromasie)**
- **D = Durchmesser über 5 mm**
- **E = Elevation / Erhabenheit (über das Hautniveau)**

21. Urolithiasis

İçindekilere dön

• Müssen Sie häufig Wasser lassen? Wie oft ? • Wie ist Ihre Urinmenge? Viel oder wenig? • Müssen Sie nachts auf die Toilette? • Haben Sie Schmerzen oder brennendes Gefühl beim Wasserlassen? • Haben Sie Änderung der Urinfarbe/Harnfarbe bemerkt? • Haben Sie Blut im Urin bemerkt? • Haben Sie einen Ausfluss aus der Scheide bemerkt?	

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf **Harnsteinleiden. Sie haben wahrcheinlich kleine Steine in den Harnwegen. Diese Steine können den Urinfluss behindern und starke Schmerzen verursachen. Das kann eine Folge des Morbus Crohn sein.**

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Urinuntersuchung und eine Bauchultraschall durchführen.. Wissen Sie, was das ist?

Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht.

Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Nun möchte ich gerne über den Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?

Es geht um Frau Sabine Wagenbach. Sie ist 45 Jahre alt**, geboren am** 11.04.1980. Sie ist 1,68 m **groß** und **wiegt** 86 kg.

Frau Wagenbach **kam heute zu uns wegen seit** anderthalb Stunden **bestehender** Schmerzen in der rechten Flanke.

Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich **aufgetreten.**

Sie **berichtet, dass die Schmerzen** in den rechten Unterbauch **ausstrahlen.**

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen stechend, kolikartig, progredient und persistierend.

Schmerzintensität liegt bei 7/10 **auf der NRS .**

Begleitend klagt sie über ungemessenes Fieber, Übelkeit, Schweißausbrüche und Hämaturie.
Vegetativ-anamnestisch ergab sich lediglich Kaltschweiß.
Die gynäkologische Anamnese war unauffällig. Ihre letzte Periode war vor 14 Tagen**, und eine Gravidität wurde verneint.**

An Vorerkrankungen leidet sie seit 20 Jahren **an** Morbus Crohn.

An Operationen ist eine lokalisierte Resektion eines Teils des Dünndarms im Rahmen des Morbus Crohn.
(vor 10 Jahren) **bekannt.**

Der Patient nimmt Budesonid bei Schüben und Ergänzungsstoffe wie Mineralien **ein.**

Allergien wurden verneint; **sie hat** eine Glutenunverträglichkeit sowie eine Empfindlichkeit gegenüber fettigem Essen.

Die Noxenanamnese war unauffällig. Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum wurden verneint.

Die Familienanamnese ergab Lungenfibrose **beim Vater,** Colitis ulcerosa **bei der Mutter** und Zwangsstörungen **bei der Schwester.**

Sozialanamnestisch ist sie Gärtnerin **von Beruf**, verheiratet und wohnt mit ihrem Mann zusammen; sie **hat** einen Sohn.

Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Urolithiasis**. Dafür sprechen** Kolikartige Flankenschmerzen mit Ausstrahlung in den rechten Unterbauch, Übelkeit, Hämaturie und die Vorgeschichte mit Morbus Crohn.
Differentialdiagnostisch kommen ein akuter Schub des Morbus Crohn, eine Divertikulitis, eine Appendizitis sowie eine Adnexitis, extrauterine Gravidität und Ovarialtorsion **in Betracht.**

Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst naturlich eine körperliche Untersuchung durchführen

Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, β-HCG, einen Urinstatus und eine Urinkultur **kontrollieren lassen.**

Darüber hinaus werde ich eine Nieren-Sonographie **durchführen,** ggf. ein Röntgen-Abdomen und ggf. ein CT-Abdomen **veranlassen.**

Ich werde ein urologisches Konsil **anfordern.**

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen.

Ich würde symptomatisch Analgetikum, Antiemetikum, Spasmolytikum **sowie** Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstition **verordnen**

Die Behandlung richtet sich nach Größe, Lage und Komplikationen des Steins.

- Bei kleinen Nierensteinen bis etwa 5–6 mm erfolgt meist eine konservative Therapie mit viel Flüssigkeit, Schmerzmitteln und ggf. Tamsulosin zur Erleichterung des Steinabgangs.
- Bei größeren Steinen oder bei Komplikationen werden interventionelle Verfahren wie ESWL, Ureterorenoskopie oder perkutane Nephrolithotomie eingesetzt.
- Bei Fieber und Harnstau ist eine sofortige Drainage und Antibiotikatherapie notwendig.